

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO EDUCACIÓN ESPECIAL-LOGOPEDIA

TESIS EN OPCIÓN AL TÍTULO DE MÁSTER EN ATENCIÓN LOGOPÉDICA INTEGRAL

TÍTULO: La atención logopédica de la disartria a partir de su integración con Terapia Ocupacional**.**

AUTOR: Lic. Beatriz Sánchez González

TUTOR: Dr. C. Héctor Núñez Guzmán

2023

Síntesis

En el presente trabajo se aborda el modo en que se pretende contribuir a la rehabilitación Logopédica de los niños (as) con disartria, mediante la implementación de una estrategia didáctica en los turnos de Terapia Ocupacional. Para profundizar en el conocimiento del desarrollo, conceptualización y tratamiento de la disartria y la historia, criterios conceptuales y formas de utilización de la Terapia Ocupacional como alternativa terapéutica en el desarrollo del lenguaje. Como solución, esta investigación se propone la utilización de una estrategia didáctica logopédica implementada en la terapia ocupacional para la rehabilitación del lenguaje de niños con disartria.

Palabras clave: Rehabilitación, disartria, Terapia ocupacional, Actividades de la Vida Diaria

Synthesis

In the present work, the way in which it is intended to contribute to the Logopedic rehabilitation of children with Dysarthria through the implementation of Occupational Therapy is addressed. To deepen the knowledge of the development, conceptualization and treatment of Dysarthria and the history, conceptual criteria and ways of using Occupational Therapy as a therapeutic alternative in language development. As a solution, this research proposes the use of a strategy of speech therapy actions implemented in occupational therapy for the rehabilitation of the language of children with Dysarthria.

Keywords: Rehabilitation, Dysarthria. Occupational therapy, Daily life activities

Índice

INTRODUCCIÓN 1

DESARROLLO 7

1- Fundamentos Teóricos y metodológicos que caracterizan la atención logopédica de la disartria. 7

2- Antecedentes históricos que han caracterizado la atención a escolares con discapacidad físico motora que presentan dificultades en el lenguaje. 32

3-Diagnóstico de la situación actual del lenguaje de los escolares con disartria de la Escuela Especial Amistad Cuba Vietnam 38

4-estrategia didáctica para la rehabilitación de la disartria a partir de su implementación en la Terapia ocupacional en escolares con discapacidad físico motora de la Escuela Especial Amistad Cuba Vietnam 42

5-Evaluación de la factibilidad y pertinencia de la estrategia didáctica para la rehabilitación logopédica de la de la disartria a partir de su implementación en los talleres de terapia ocupacional en la Escuela Especial para niños con discapacidad físico motora Amistad Cuba – Vietnam 61

CONCLUSIONES 67

RECOMENDACIONES 68

INTRODUCCIÓN

El lenguaje es la base de la comunicación del ser humano, nos permite expresarnos y comprender a los demás, dependiendo de cómo lo utilicemos, vamos a construir e interpretar el mundo de manera diferente. La aptitud para expresarse se manifiesta en la capacidad humana para comunicar pensamientos y sentimientos a través de las palabras. Gracias al lenguaje dotamos de significados a los objetos y acciones que realizamos pues este dentro de su función reguladora nos permite planear acciones y solucionar problemas. Estas capacidades estarán disminuidas en los niños con trastornos del lenguaje resultándoles más difícil enfrentar y desempeñar situaciones y acciones de la vida diaria, como es el caso de los niños con disartria.

La disartria es un trastorno orgánico del lenguaje de carácter neurológico, provocado por lesiones en regiones centrales y en las vías conductoras del analizador verbo motor. En todos los casos se hace evidente la insuficiente inervación de los órganos que intervienen en la emisión del habla, lo que trae como consecuencia trastornos en la pronunciación, acompañados por lo general de afecciones respiratorias, el ritmo, la velocidad, la modulación, la entonación, la voz y del aspecto léxico-gramatical del lenguaje. La severidad que caracteriza el trastorno en la mayor parte de los casos hace que algunos autores la consideren como la más difícil y completa afectación en el aspecto sonoro del lenguaje.

También debemos conocer que la disartria tiene diversas causas (etiología): aparece como resultado de una lesión del SNC. Constituye un síntoma de las parálisis cerebrales, se encuentran con mayor frecuencia en la edad temprana (surge ante de los dos años) motivada por traumas o por procesos inflamatorios del cerebro (meningitis, meningoencefalitis, trastornos vasculares). Con regularidad las parálisis cerebrales aparecen como resultado de traumas prenatales (el 80% según los autores) y se hacen más complejas en el momento del parto por influencias de noxas perinatales (traumas físicos del cerebro, hemorragias etc.)

Los trastornos disártricos pueden estar condicionados por lesiones o por el insuficiente desarrollo de diferentes sistemas cerebrales: corticobulbar o piramidal, cerebelar, formación reticular, zona subcortical verbomotriz, etc. En los niños constituye generalmente un síntoma de las parálisis cerebrales.

Por otra parte la parálisis cerebral como lesión estática del sistema nervioso central además de afectar el movimiento, la postura y la comunicación humana es uno de los trastornos infantiles que más limita la realización de Las actividades físicas, y por tanto la realización de las actividades de la vida diarias que requieren de los movimientos corporales, algunos de estos tan sencillos como alcanzar un objeto, aislarlo o seguirlo con la mirada al moverse. Que se adquieren muy temprano y dependen en gran parte de los patrones innatos y de la estimulación de estos por el adulto. Todos los movimientos del hombre se realizan con la participación del Sistema Nervioso Central este posee secciones importantes (médula espinal, bulbo raquídeo, mezo encéfalo, di encéfalo, cerebelo, y los grandes hemisferios) y cada una de ellas desempeña un papel en el movimiento lo cual quiere decir que cuando está presente la afectación cerebral y/o neurológica dichos movimientos se entorpecen limitando la amplitud articular. Partiendo de estas consideraciones, el adiestramiento psicomotor tiene gran valor para el individuo, ya que es indispensable en el desenvolvimiento de las tareas diarias durante toda la vida y que una vez adquiridas se convierten en actos mecánicos socialmente indispensables. En el caso de los estudiantes con limitaciones físico motoras asociados a parálisis cerebral cobra una mayor importancia, ya que mediante este, se le proporciona la cantidad suficiente de experiencias, a través de las cuales se puede lograr incrementar el control sobre su cuerpo, las dimensiones espacio corporales así como el conocimiento del medio, y la participación e interacción con el mismo a través de las actividades de la vida diaria y del lenguaje oral para el mejoramiento de su calidad de vida y su inclusión en la sociedad.

La Terapia Ocupacional es una ciencia que se dirige principalmente a la rehabilitación y habilitación de personas que han visto alteradas sus capacidades para desenvolverse normalmente (a nivel físico y/o intelectual) como consecuencia de problemas en el desarrollo de las personas, del proceso de envejecimiento, de enfermedades mentales o problemas emocionales. Los objetivos de la terapia ocupacional son conseguir y alcanzar, el mayor grado de independencia posible en las personas, a través de las actividades terapéuticas. La Terapia Ocupacional ve al hombre como un ser biopsicosocial, y lo ayuda a adquirir o recuperar habilidades dañadas o perdidas por cualquier causa, para insertarlo a la sociedad.

El desarrollo del autovalidismo es un aspecto importante a desarrollar dentro de las escuelas para niños con discapacidad físico motora ya que son las acciones que el individuo realiza en función de resolver necesidades básicas como: lograr adquirir un buen equilibrio para desplazarse hacia cualquier parte, bañarse, vestirse, desvestirse, alimentarse, y la posibilidad de relacionarse y resolver sus problemas sociales de forma independiente, teniendo en cuenta que los escolares de nuestro centro presentan como defecto primario dificultades en la actividad motriz que les limita caminar, correr saltar, trasladarse en diferentes direcciones, manipular objetos, realizar movimientos pre articulatorios para el lenguaje, masticar, tragar y por tanto comunicarse.

En la actualidad la implementación de sistemas y actividades de tratamiento para la atención logopédica a niños con disartria son efectivos pero no son suficientes lo cual se ve reflejado en:

- El pobre desarrollo del lenguaje y la comunicación oral en los niños disártricos de la escuela especial Amistad Cuba Vietnam debido a la insuficiente implementación de programas terapéuticos y rehabilitadores que se utilicen en función de favorecer la atención logopédica de esta patología, así como el desaprovechamiento de los recursos y el tiempo que aportan estos programas para su aplicación en la rehabilitación de esta patología.

En la presente investigación se implementará la terapia ocupacional para la rehabilitación logopédica de la disartria una modalidad de tratamiento que aportan las tecnologías de la salud en el perfil de rehabilitación social y ocupacional, que constituye un proceder muy generalizado en nuestros días en el servicio hospitalario y en salas de rehabilitación aplicándose a niños adolescentes y adultos y que resultará de gran utilidad y apoyo en una ciencia tan importante como la logopedia.

Esta estrategia se aplicará a partir del trabajo con las actividades de la vida diaria y el desarrollo del autovalidismo de los escolares, a través del programa de terapia ocupacional del centro implementando en esta las acciones logopédicas dirigidas a corregir y o compensar los trastornos del lenguaje y la comunicación oral además de lograr una mayor inclusión social de los escolares con esta patología. Esta terapia es complementaria y se realizará con el fin de propiciar un reajuste funcional que facilite el desarrollo de la comunicación oral en el tratamiento logopédico.

Todo lo antes expuesto permitió corroborar la opinión ya existente de que los tratamientos logopédicos como parte del proceso docente educativo y correctivo de la disartria requiere de un tratamiento correctivo – compensatorio más selectivo, sistemático y creativo, elementos que conllevan a plantear el siguiente

Problema científico: ¿Cómo propiciar el desarrollo del Lenguaje y la comunicación oral en niños disártricos de la escuela especial Amistad Cuba Vietnam?, teniendo como **Objeto de investigación**: La atención logopédica integral a escolares con disartria. Se define como **Objetivo de investigación**: Diseñar una estrategia didáctica en función de desarrollar el lenguaje oral en niños portadores de disartria de la Escuela Especial Amistad Cuba Vietnam a partir de la Integración de la atención logopédica con las clases de terapia ocupacional.

Respondiendo al **Campo de acción**: El empleo de la Terapia Ocupacional en escolares con disartria. Teniendo como Título: La atención logopédica de la disartria a partir de su integración con la Terapia Ocupacional. Durante la investigación se plantearon las siguientes

Preguntas Científicas:

1. ¿Cuáles son las posiciones teóricas que sustentan la atención logopédica en niños con disartria?
2. Cuáles son las tendencias históricas que caracterizan el proceso de atención logopédica y rehabilitación del escolar con discapacidad físico motora que presenta dificultades en el lenguaje.
3. ¿Cuáles son los resultados de la situación actual en cuanto a la atención logopédica a los niños disartria de la escuela Amistad Cuba Vietnam?
4. ¿Qué estrategia didáctica serán viable para aplicar en el programa de terapia ocupacional del centro en función de rehabilitar el lenguaje en niños disártricos de la escuela especial Amistad Cuba Vietnam?
5. ¿Qué efectividad tendrá la aplicación de una estrategia didáctica durante los turnos y talleres de terapia ocupacional para el desarrollo Del Lenguaje y la comunicación oral de niños disártricos de la escuela especial Amistad Cuba Vietnam?

A modo de darle respuesta a las preguntas científicas se definen las siguientes

Tareas científicas:

1. Determinar los fundamentos teóricos en el proceso de atención logopédica en niños con disartria.
2. Determinar las tendencias históricas que han caracterizado el proceso de atención logopédica y rehabilitación del escolar con discapacidad físico motora con dificultades en el lenguaje.
3. Diagnosticar la situación actual de la atención logopédica en niños disártricos de la escuela especial Amistad Cuba Vietnam.
4. Aplicar la estrategia didáctica en los turnos de Terapia Ocupacional para complementar la Rehabilitación del lenguaje a niños disártricos de la escuela especial Amistad Cuba Vietnam.
5. Valorar la efectividad de la aplicación de una estrategia didáctica en los turnos de Terapia Ocupacional para el desarrollo del Lenguaje y la Comunicación oral de los niños disártricos de la escuela especial Amistad Cuba Vietnam.

Métodos teóricos utilizados:

Análisis-Síntesis: para valorar los elementos teóricos relacionados con la temática del objeto de investigación, y para sintetizar las ideas fundamentales.

Inductivo-deductivo: se utiliza con el objetivo de analizar los elementos teóricos que abordan la temática y poder aplicarlos de forma específica en la investigación de lo general a lo particular.

Modelación: para elaborar la propuesta la estrategia didáctica para la rehabilitación logopédica de la disartria.

Métodos Empíricos:

Observación: se realizó a talleres de terapia ocupacional para determinar la eficiencia de la aplicación de la estrategia didáctica en la rehabilitación logopédica de la disartria en escolares con discapacidad físico motoras.

Entrevistas: se realizó a especialistas, docentes, y familiares para comprobar si después de aplicada la propuesta los escolares han tendido un incremento en su lenguaje.

Encuesta a especialistas: Con el objetivo de evaluar la efectividad de la propuesta.

Métodos Estadístico-Matemático, este se utiliza para el procesamiento y análisis cuantitativos y cualitativos obtenidos en el diagnóstico inicial y final.

Población: La población está determinada por un total de 16 especialistas de primer ciclo. La muestra la integran un total de 4especialistas de primer ciclo.

Variables fundamentales:

Variable independiente: estrategia didáctica para su implementación en la rehabilitación de la disartria durante las actividades de terapia ocupacional

Para evaluar los resultados de esta variable se tuvo en cuenta el siguiente **indicador:**

1-Sistematicidad de aplicación de las acciones orientadas en los turnos de terapia ocupacional.

Variable dependiente: desarrollo de la expresión oral. Para medir el comportamiento de la variable dependiente se tuvieron en cuenta los siguientes **indicadores:**

1-Calidad de la comunicación atendiendo a:

2- Desarrollo de vocabulario activo y pasivo

3- Independencia verbal

4- Desarrollo de la motricidad articulatoria

5-Respiración fisiológica en función del habla.

Unidad de observación: niños disártricos de la escuela especial Amistad Cuba Vietnam.

Novedad científica: radica en la propuesta de la implementación de la Terapia Ocupacional en la rehabilitación logopédica de la disartria con el fin de propiciar el desarrollo del lenguaje y la comunicación oral en los niños disártricos de la escuela especial: Amistad Cuba Vietnam. La propuesta que se realiza pone en manos del logopeda un material que sin desconocer la metodología tradicional que se utiliza para la corrección compensación de la disartria, permite desarrollar niveles de creatividad y flexibilidad en su tratamiento.

Este trabajo está vinculado al proyecto: Inclusión social y educativa de niños adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales en Santiago de Cuba. Línea de investigación: la atención educativa integral a niños con trastornos del lenguaje.

DESARROLLO

1- Fundamentos teóricos y metodológicos que caracterizan la atención logopédica de la disartria.

Uno de los trastornos del lenguaje de mayor severidad y complejidad lo constituye la disartria, que se conceptualiza como:

> El término disartria proviene del griego dis, dificultad y arthron, articulación, es decir, se trata de un trastorno orgánico del lenguaje de carácter neurológico, debido a lesiones en regiones centrales y en las vías conductoras del sistema motor verbal. Se presenta una insuficiencia en la inervación de los órganos que intervienen en la emisión del habla, como consecuencia se producen trastornos en la pronunciación, acompañados de alteraciones respiratorias, el ritmo, la velocidad, la entonación, la voz y el aspecto léxico-gramatical de la lengua; por sus particularidades se considera la alteración más compleja del componente sonoro del lenguaje. (Fernández Pérez de Alejo & Rodríguez Fleitas, 2012, p. 143)

Ernesto Figueredo en el libro Logopedia Parte 1 expresa que la disartria “es un trastorno orgánico del lenguaje de carácter neurológico, provocado por lesiones en regiones centrales y en las vías conductoras del analizador verbomotor” (Figueredo Escobar et al., 1984, p. 106). Se hace evidente la inervación insuficiente de los órganos articulatorios, lo que produce alteraciones en la pronunciación de los sonidos, acompañados por lo general de afectaciones en los atributos vocales, y toma de los movimientos biológicos. Su pronóstico está en relación con el síndrome neurológico de base, así como el diagnóstico e inicio del tratamiento. El diagnóstico diferencial se realiza con las dislalias y la afasia motriz aferente.

Podemos definir también a la Parálisis Cerebral Infantil como: "desorden permanente y no inmutable del tono, la postura y el movimiento, debido a una lesión cerebral antes de que su desarrollo y crecimiento sean completos” (San Pedro Virués, 2008, p. 1).

La parálisis cerebral afecta los principales sistemas motores del cuerpo:

El área motora piramidal o neurona motriz superior se localiza sobre la circunvolución precentral (anterior a la cisura de Rolando) o región de la motilidad voluntaria. La lesión de las neuronas motrices superiores afecta los movimientos voluntarios, y por

consiguiente al habla, originando alteraciones en la función muscular: espasticidad, debilidad, limitación de alcance y lentitud de movimientos.

1º Síndrome piramidal: a) déficit motor voluntario, b) debilitación o pérdida de los reflejos cutáneos, c) sincinesias, d) exageración de los reflejos clínicos por percusión, e) aumento de los reflejos nocioceptivo flexores, f) hipertonía espástica, g) atrofia por desuso.

El área motora extrapiramidal está determinada por los centros motores subcorticales controlados por el contexto en el ámbito de grupos de núcleos. La lesión de las neuronas del área extrapiramidal afecta los movimientos involuntarios e impulsivos, así como al control de la automotricidad de la marcha y la carrera.

2º Síndromes extrapiramidales:

I Síndrome hipertónico-hipercinético: a) rigidez, b) temblor, c) hipocinesia, d) bradicinesia, e) paresia global.

II Síndrome hipotónico-hipercinético: a) movimientos coreicos, b) disartria, c) hipotonía, d) hipercinesia.

III Síndrome distónico-hipercinético: a) movimientos atetósicos, b) distonías, c) hipercinesia, d) actitudes posturales anómalas.

3º Síndrome cerebeloso: a) ataxia con dismetría, asinergia y adiadococinesia, b) desequilibrio, c) hipotonía, d) palabra escandida, e) nistagmus, f) abarognosia.

Los trastornos de estas estructuras del sistema nervioso se manifiestan como trastornos del tono muscular y como trastornos del movimiento.

Trastornos del tono muscular:

* Hipertonía: consiste en el aumento del tono muscular que se ponen de manifiesto tanto en el tono de reposo como en el de actividad. Esencialmente es de tres tipos: la espasticidad, la rigidez y la tensión.

* Hipotonía: consiste en una anormal disminución del tono muscular permanente.

* Distonías y espasmos: consisten en el aumento paroxístico del tono de un grupo de músculos.

* Actividad tonicopostural anormal: las lesiones centrales provocan con frecuencia un fallo de la actividad tonicopostural normal.

* Dismimias: llamadas alteraciones de la expresión gestual.

Trastornos del movimiento:

* Movimientos anormales: se les llama también involuntarios porque aparecen espontáneamente, escapando al control de la voluntad. Podemos encontrar dos tipos: coreicos (bruscos, breves, irregulares y desordenados, discontinuos, súbitos y sin ritmo) y atetósicos (lentos y acostumbran a ser repetitivos); como ejemplo de ello tenemos los "tics".

* Paresias y parálisis: se llama paresia a la disminución de la fuerza muscular, y la parálisis a la pérdida completa de dicha fuerza (fuerza muscular voluntaria).

* Sincinesias: es una manifestación característica de la organización anómala de la motricidad. Distinguimos tres tipos: sincinesia global, sincinesia de imitación y sincinesia de coordinación.

* Ataxia: es un fallo en la coordinación de un trabajo conjunto de los músculos que intervienen en cada movimiento. También llamada incoordinación del movimiento, puede deberse a tres tipos: fallo de información, fallo de la coordinación como tal y ataxia por interferencia en el acto motriz.

* Dispraxias y apraxias: la apraxia (o dispraxia) consiste en un trastorno de la motricidad que no se refiere a un fallo de la realización del acto motriz ni a la persistencia de esquemas motrices anómalos, sino a un fallo de la propia organización del acto motriz.

El hecho de reconocer a la disartria como el síntoma oral de las parálisis cerebrales está condicionado por la lesión que se produce en los centros motores del encéfalo, lo que ocasiona alteraciones del tono y el movimiento.

La disartria aparece como resultado de una lesión en el sistema nervioso central, surge como un síntoma de las parálisis cerebrales, se encuentra con mayor frecuencia en la edad temprana (surge antes de los dos años), motivadas por traumas o procesos inflamatorios del cerebro (meningitis, meningoencefalitis, trastornos vasculares). Con regularidad, las parálisis cerebrales aparecen como resultados de traumas prenatales y se hacen más complejas en el proceso del parto por influencia de noxas perinatales (traumas físicos de cerebro, hemorragias etc.) (Fernández Pérez de Alejo & Rodríguez Fleitas, 2012).

Los trastornos disártricos pueden estar condicionados por lesiones o por el insuficiente desarrollo de diferentes sistemas cerebrales: corticobulbar o piramidal, cerebelar, formación reticular, zona subcortical verbomotriz etc.

Pares de nervios craneales que se afectan en el escolar disártrico:

Los nervios craneales son 12 pares que parten, en su mayoría, del tallo cerebral y se originan en uno o más núcleo de sustancia gris. Según los tipos de fibras que presentan, se clasifican, en sensitivo, motores y mixtos.

Nervios XII o hipogloso: Es un nervio motor, que tiene su origen en el llamado núcleo motor del hipogloso, constituido por neuronas motoras alfa y gamma, cuyos axones terminan en la base de la lengua y forman unidades motoras en los diferentes músculos de este órgano. Este nervio también inerva las fibras musculares intrafusales de los husos musculares de la lengua.

La lesión unilateral del nervio hipogloso produce una parálisis de la mitad ipsilateral de la lengua, con pérdida total del movimiento en dicha mitad, perdida del tono y atrofia degenerativa de los músculos afectados, por lo que, al sacar la lengua, esta se desvía hacia el lado afectado.

La lesión bilateral de los nervios XII provoca la atrofia de ambas mitades de la lengua y la inmovilidad completa de la misma; lo que trae como consecuencia la alteración del lenguaje y la dificultad para empujar el bolo alimenticio en la cavidad nasal.

Nervio X o vago (o neumogástrico): Es un nervio mixto, que se origina en tres núcleos del tronco encefálico. Los axones de las neuronas del núcleo motor somático inervan músculos estriado de la faringe y de la laringe, entre otros efectores. La lesión unilateral de este nervio causa parálisis unilateral del paladar blando de la faringe y de la laringe, cuyas consecuencias son disnea, disfagia y ronquera. La destrucción bilateral d los nervios vagos provoca parálisis laringe completa, atonía y parálisis del esófago y del estómago (estas últimas inducen dolor y vomito). También existe una pérdida de los reflejos respiratorios vágales, disnea, y aceleración cardiaca.

Nervio IX o glosofaríngeo: Este es un nervio mixto que, al igual que el nervio vago, se origina en un núcleo motor somático, un núcleo motor vegetativo y un núcleo de neuronas intercaladas. A este último llega la información procedente de los receptores situados en la caja timpánica, en la trompa de Eustaquio, en la piel del conducto auditivo externo, en las amígdalas, en las papilas gustativas del tercio posterior de lengua y en los quimioceptores y preceptores del seno carotídeo. Los axones de las neuronas situadas en el núcleo motor somático inervan a los músculos estriados superiores de la faringe,

principalmente del velo del paladar. Las lesiones exclusivas de este nervio son poco frecuentes, los síntomas más importantes incluyen la pérdida del reflejo faríngeo (nauseoso) y del seno carotídeo, así como la pérdida del gusto en el tercio posterior de la lengua. En general, los núcleos de los nervios craneales, IX, X, XII pueden ser lesionados por focos patológicos relativamente pequeños que provocan parálisis periféricas de estos nervios, lo que se manifiesta por alteración de la deglución (disfagia), perdida de la sonoridad de la voz (afonía), matiz nasal de la voz (nasolalia) y alteración de la pronunciación correcta de los sonidos(disartria).

Nervio VII o facial: Este es un nervio mixto, que se origina en tres núcleos de sustancia gris, uno motor somático, uno vegetativo y otro de neurona intercalada. Los axones de las neuronas del núcleo motor somático terminan en los músculos faciales de la expresión (frontales superficiales, orbiculares de los parpados, buccinadores y orbiculares de los labios, entre otro). Los axones de las neuronas motoras del núcleo vegetativo terminan en dos ganglios que se encuentran muy cerca de los efectores: las glándulas submaxilares, sublinguales y lagrimales y la mucosa palatina y nasopalatina.

La lesión completa de la parte motora somática del nervio facial produce una parálisis total ipsilateral de los movimientos faciales (incapacidad para arrugar la frente, cerrar los ojos, mostrar los dientes, soplar y silbar). Si se lesiona la parte vegetativa del nervio, hay trastornos en la secreción de saliva por las glándulas submaxilares y sublinguales. Si se afectan las fibras sensitivas hay trastorno del gusto sobre los dos tercios anteriores de la lengua.

Nervio V o trigémino: Este es un nervio mixto que se caracteriza por presentar tres ramas, la superior u oftálmica, la intermedia o maxilar y la inferior o mandibular. Estas ramas están constituidas por las expansiones periféricas de las neuronas sensitivas monopolares situadas en un ganglio y que se relaciona en la órbita, los párpados, las fosas nasales, la frente, el cuero cabelludo, la región infraorbitaria, la temporal anterior, las arcadas dentarías, la bóveda palatina, parte de la mucosa nasal, mucosa de la lengua, entre otras.

Las lesiones unilaterales de la porción motora de este nervio dificultan la masticación en el lado de la lesión y al abrir la boca la mandíbula se desviara hacia el lado afectado. Si se lesionan las fibras sensitivas se perderá la sensibilidad dolorosa, térmica. A veces este

nervio puede afectarse por procesos imitativos, entonces aparecen episodios de dolor intenso en la cara. Esto se denomina neuralgia del trigémino.

Clasificación de la disartria según Darley, Aronson, Brown y modificada por Prater por el sitio de la lesión las disartrias se clasifican en:

disartria por trastornos de la moto neurona superior.

disartria por trastornos de la moto neurona inferior.

disartria por trastornos cerebelosos

disartria por trastornos extrapiramidales

disartria por trastornos de múltiples sistemas motores. (Alvarez Lami, 2016)

Por la localización de la lesión, Figueredo refiere que se manifiestan en 5 formas:

En la disartria bulbar, se presentan lesiones unilaterales y bilaterales en los núcleos de los nervios craneales bulbares y salientes; su frecuencia es relativa, se producen severas afectaciones cardíacas y de la respiración que por lo general ocasionan la muerte.

En la disartria pseudobulbar, las lesiones se producen en las vías piramidales que transmiten los impulsos nerviosos desde la corteza a los núcleos bulbares. Se reconoce como la más frecuente de todas las formas de disartria. Como resultado de la lesión del nervio facial, se alteran los movimientos coordinados de los labios, el cierre de la mandíbula se hace insuficiente, se presenta una acumulación de saliva. Todo ello dificulta de forma severa la pronunciación de los sonidos verbales. También, por la lesión del nervio vago, se afecta además la respiración y la voz, por la insuficiente inervación de los músculos de la laringe y las cuerdas vocales. En este caso, la voz es débil, ronca, poco modulada, con marcada resonancia nasal; el ritmo es lento y el lenguaje carece de expresividad. Generalmente, aparece por secuelas de encefalitis o traumas en las edades tempranas cuando se inicia el desarrollo del lenguaje.

En los casos menos severos se afectan solo sonidos aislados, pero el lenguaje contextual no es coordinado, se manifiesta de manera ininteligible. A este tipo de disartria, algunos autores como O. V. Pravdina, le denominan disartria discreta. En el diagnóstico diferencial se puede confundir con la dislalia, pero su corrección es mucho más compleja.

En la disartria cerebelar o cerebelosa, las lesiones se producen en el cerebelo y en las vías conductoras cerebelares, las que ocasionan una alteración en la fluidez del lenguaje (habla con silabeo), la intensidad de la voz y la marcha.

En la disartria subcortical, la lesión se ubica en los nódulos subcorticales, el ejemplo típico se da en la enfermedad de Parkinson. Se caracteriza por un tono de voz bajo, lenguaje monótono y la articulación poco clara. También el ritmo se acelera o se retarda demasiado.

La disartria cortical, se considera como secuela de una lesión en la corteza que no tiene lugar en la Zona de Broca (no es tan amplia en cuanto a su dimensión), esta forma es poco estudiada y puede aparecer acompañada de trastornos afásicos. La pronunciación se afecta como en la dislalia.

La neurología clínica, al estudiar las alteraciones motrices generales precisa como síntomas clínicos que aparecen en la disartria los siguientes:

Espástico-parético; su síntoma central es la paresis espástica y la forma más difundida del trastorno en las parálisis cerebrales. Se produce un debilitamiento o pérdida de la inervación muscular de los diferentes nervios craneales. Los niños presentan grandes dificultades para encontrar la posición articulatoria correcta, se producen trastornos en la intensidad y sonoridad de la voz, el lenguaje es impreciso, la entonación también está afectada y la respiración es poco profunda. La amplitud de los movimientos articulatorios siempre es insuficiente. Todo ello tiene una implicación en las alteraciones del lenguaje escrito.

Espástico-rígida; prevalece la paresis espástica y las alteraciones tónicas en la dirección de los movimientos del tipo rígido. La parálisis espástica en los músculos interviene en el acto del lenguaje; la presencia de la rigidez con un estado activo de las secciones del tallo cerebral, se expresan en el aumenta el tono muscular.

Hipercinésica; prevalece la hipercinesia (movimientos coreicos, atetósicos, mioclonia), depende de la localización de la lesión en el sistema extrapiramidal. La aparición de la hipercinesis en los músculos del aparato articulatorio provoca graves trastornos en la pronunciación de los sonidos del idioma, incluso a veces es imposible la producción del lenguaje. También se afectan las sensaciones cinestésicas en la esfera de la articulación, las que dan lugar a las dispraxias. Puede aparecer en estado de reposo o en el proceso de realización de los movimientos involuntarios, se afecta la masticación y la deglución, la voz es tensa, vibrante, cambia el tono y la intensidad. En casos aislados se acompaña de convulsiones epilépticas.

Atáxica; prevalece la ataxia con afectaciones asimétricas y asinérgicas de los movimientos articulatorios; se pierde la coordinación, la amplitud y la velocidad de los movimientos.

Espástico-atáxico; espástico-hipercinésico; atáxico-hipercinésico; se combinan en las distintas formas en que se manifiesta este trastorno.

En el niño, los síntomas disártricos son, en ocasiones, difíciles de diferenciar de los vinculados a la maduración sensorio–motriz del sistema fono-articulatorio, se encuentran errores de la articulación asociados a una lesión neurológica (disartria), o a un retraso en la adquisición de habilidades perceptivo–motrices para producir un sonido concreto de lu lengua o ambas. Cuando no se conoce la causa se puede confundir con una dislalia o con un retraso del habla (Figueredo Escobar et al., 1984).

En los escolares disártricos se altera el lenguaje expresivo el cual se define de la siguiente manera: es un proceso complejo que comprende la pronunciación, supone una actividad motora precisa y una organización serial bien establecido, así como la retención de un esquema general de la frase u oración, por lo cual intervienen varias áreas del encéfalo. Está directamente relacionado con la producción del lenguaje, es la exposición del pensamiento a través del lenguaje oral, la producción depende en cierto grado de la comprensión. Antes de la emisión de la palabra esta la adquisición de significados.

Con frecuencia se evidencia una alteración en la motricidad articulatoria lo que conlleva a que el niño tenga dificultad para describir experiencias, decir diferencias y semejanzas entre objetos, contesta las preguntas de manera difusa, tiende a contestar “no sé”, dando respuestas breves, presenta un vocabulario limitado, evita actividades verbales, puede negarse a leer en voz alta. Presenta dificultades en la adquisición de las palabras ya que presenta una gama reducida del vocabulario, dice frases expresivamente cortas, las estructuras gramaticales que poseen son simples, además tienen un desarrollo lento del lenguaje. Todo esto antes mencionado son algunas de las particularidades del lenguaje expresivo en un escolar con disartria. Se presentan grandes dificultades para escribir, pintar, entre otras cosas.

En este trastorno (disartria) también se distingue el carácter primario y secundario por las consecuencias que provoca para la formación y desarrollo de la personalidad. Los de

carácter primario, detectan los trastornos de la motricidad articulatoria, de la pronunciación, la respiración, la voz, la entonación y la motricidad general.

Los trastornos de carácter primario tienen que ver con la alteración del componente sonoro del lenguaje y el síntoma clínico que prevalece como resultado de la lesión neurológica, la que ocasiona trastornos en la motricidad general y articulatoria en este caso se señalan los siguientes:

Trastornos de la motricidad articulatoria: los movimientos en los niños disártricos son superficiales, poco fluidos, pueden iniciarse y no llegan a realizarse totalmente, son insuficientes débiles. El cambio de un movimiento a otro puede ser con dificultades, demorado, a veces la lengua se desvía hacia la derecha o la izquierda y no se consigue el movimiento.

Trastornos de la pronunciación: por la paresis y parálisis se omiten muchos sonidos, se producen sustituciones y distorsiones, incluso en la búsqueda de la posición articulatoria correcta provoca la inconstancia en la pronunciación.

Trastornos de la respiración: los disártricos respiran de manera superficial, frecuentemente clavicular, tienden a hablar durante la inspiración, lo que produce una sensación de ahogo.

Trastorno de la voz: estas alteraciones son resultado de las parálisis y paresis de las cuerdas vocales, del velo y los trastornos de respiración. La voz puede presentarse ronca, nasal, poco modulada; se evidencian trastornos en la intensidad, el tono y el timbre.

Trastornos de la entonación: las alteraciones del componente sonoro en general, dificultan el lenguaje oral en cuanto a su expresividad, se revela un habla monótona y poco modulada. Se altera la velocidad (acelerada o retardada), se observan pausas innecesarias. En algunos tipos de disartria es característico mantener la boca abierta, el babeo constante por los trastornos de la deglución.

Trastornos de la motricidad general: se evidencian en la torpeza, inexactitud e imprecisión de los movimientos, aumento o disminución del tono muscular, se afecta la coordinación motriz de los dedos.

Las alteraciones en la motricidad y el insuficiente desarrollo del oído fonemático, los que producen trastornos en la pronunciación de los sonidos del idioma, tienen una incidencia significativa en los trastornos de la lectura y la escritura, en el resto de los componentes

de la lengua, se afecta el vocabulario, la construcción gramatical, así como su desarrollo psíquico, los que se consideran trastornos de carácter secundario.

En la lectura se producen sustituciones, omisiones, trasposiciones se sonidos que alteran la estructura silábica de la palabra. En ocasiones tienen dificultades para reconocer y diferenciar las grafías. En la escritura persisten estas y además, muestran dificultades en los trazos de las letras.

Todo ello incide en el resto de los componentes de la lengua, esencialmente se evidencia en el desarrollo del vocabulario y el uso y comprensión de estructuras gramaticales. El insuficiente desarrollo del lenguaje y del pensamiento dificulta su ubicación en el marco de la escuela regular, por ellos son tributarios de la escuela específica para trastornos severos del lenguaje.

Para el trabajo con los componentes fónico, léxico y gramatical de la lengua se tendrán en cuenta los siguientes ejercicios:

Fónico:

Emitir vocales exagerando la pronunciación

Identificar las consonantes y decir cómo suenan

Práctica fonética con sílabas directas dobles, vocales y diptongos.

Léxico:

Escuchar una orden y explicar lo que significa el mensaje.

Se presentan diferentes situaciones comunicativas para valorar.

El empleo de sinónimos y antónimos, la narración, la descripción el diálogo, otras.

Gramatical:

Responder a preguntas donde se empleen diferentes categorías gramaticales.

Describir una lámina.

Narrar una vivencia.

De acuerdo a la atención a la disartria se plantea que Cuba actualmente ha desarrollado todo un sistema de atención a las personas con discapacidades, lo que tiene un carácter principalmente preventivo, se perfeccionan continuamente los programas escolares, la preparación familiar, comunicativa y la superación profesional de la enseñanza especial para elevar la calidad de la educación para todos y fortalecer el vínculo educación–sociedad, garantizando el tránsito de estos escolares en la Enseñanza General Primaria.

Se orientan las actividades a los mismos por el mismo programa de la educación general, incluyendo las asignaturas de la especialidad como: Desarrollo de la pronunciación y el trabajo en logopedia.

En Cuba, los principios que se sustentan en la atención a los trastornos de aprendizajes son básicamente, el preventivo, multidisciplinario, epidemiológico y el personológico los cuales se integran a los dos modelos existentes: el modelo clínico y el educativo, ambos operan con los aspectos psicopedagógicos que deben tenerse en cuenta para aprender. Estos se interrelacionan entre sí, el modelo clínico y el modelo psicopedagógico, que de manera interdisciplinaria se ponen en práctica en las instituciones pediátricas de salud y en las educacionales, tanto en la enseñanza general como en la especial, respectivamente.

El fundamento del modelo clínico parte de una concepción del ser humano en tres dimensiones: biológica, psicológica y social, que combina los postulados de las teorías cognitivas y humanistas con un enfoque asistencial. En este modelo se realizan diagnósticos con pruebas computarizadas especializadas, electrofisiológicas, entre otras, que arrojan indicadores de alteraciones de funciones psiconeurológicas, relacionadas con funciones perceptivo-motoras, desarrollo del lenguaje y rendimiento académico, tomando como base la madurez de funciones cognitivas vinculadas al desarrollo de las habilidades cerebrales, todo lo cual responde a un modelo clínico. En estos casos de los niños con disartria requieren de atención neurológica, psicológica, fisioterapéutica para complementar la atención integral a largo plazo en muchos de los casos por la severidad del tratamiento.

El tratamiento debe iniciarse lo más precozmente posible. El tratamiento consiste en someter al niño a una serie de estimulaciones que faciliten su evolución psicomotriz normal y evitar todo aquello que favorezca las respuestas motrices anormales. La técnica de educación de las madres consiste en preparar a las madres de forma que sepan en qué posturas deben colocar a sus hijos para no desencadenar toda su movilidad refleja y a la vez que aprendan cómo relacionarse con el niño.

A partir de los tres años ciertos aspectos del tratamiento deben ser aplicados ya por personal especializado.

Tratamiento logopédico: el tratamiento es complejo y requiere un equipo compuesto por el neurólogo, el pediatra, el foníatra, el oftalmólogo, el ortopeda, el psicólogo y el logopeda. Si la parálisis cerebral se descubre precozmente antes de la aparición normal del lenguaje, la madre desempeña un papel importantísimo en su eclosión. Cuando el pequeño en su balbuceo produce sonido parecido a un fonema, la mamá debe repetirlo incansablemente hasta que aquel lo vuelva a repetir varias veces. Para que el niño adquiera el lenguaje es necesario que vea cosas, que se mueva, que las pueda coger. Son muy útiles los libros de imágenes, las historietas que se cuentan con gestos, las canciones infantiles, tanto para enriquecer el vocabulario como para dar entonaciones y la melodía del habla.

Los familiares del niño no deben emplear con él un vocabulario complicado ni tener conversaciones superiores a su capacidad.

El lenguaje es muy influenciable por las emociones y por los fracasos lingüísticos. El niño y su expresión verbal deben rodearse de una atmósfera de comprensión y ternura. No hay que agobiar al niño, sino que es conveniente que además él trate con niños normales para su estímulo.

Pasos:

Relajación general.

Masticación y deglución.

Audición.

Respiración.

- fonación.

- articulación.

Creación del lenguaje interior.

Comunicación con artificios. Comunicación aumentativa.

La estrategia general de la atención logopédica en caso de disartria tiene como objetivo corregir y/o compensar la alteración del componente sonoro del lenguaje y la motricidad general y articulatoria, así como la formación de la personalidad.

1**. Psicoterapia**: debe estar presente en todas las sesiones de trabajo y se basa en tres elementos fundamentales: rodear al niño de una atmósfera de afecto y comprensión; darle seguridad y confianza, estimular sus éxitos y alentarlo en el trabajo.

2. **Lucha para eliminar el babeo**: Es necesario explicar al niño que él debe tragar la saliva que se le acumule en la boca, sobre todo cuando va hablar o cuando va a realizar cualquier ejercicio articulatorio. Al principio, cuando aún tienen dificultades para la deglución, se le debe inclinar un poquito la cabeza hacia atrás, lo que facilita dicha función. El niño debe aprender a cerrar la boca y mantenerla cerrada.

3. **Técnica del masaje**: Se realiza con el objetivo de estimular la musculatura facial y articulatoria. Debe hacerse con las manos limpias y entalcadas. El logopeda garantizará una posición adecuada, hará sentar al niño en una silla, apoyando la cabeza sobre el abdomen del logopeda, que se situará detrás de él y procurará que la ropa y el pelo no toquen la región del cuello; el niño debe estar relajado, los primeros ejercicios deben ser suaves, se realizan con la yema de los dedos, haciendo movimientos lentos acariciadores en el cuello, desde la región del pecho hacia el mentón y hacia los oídos. Al llegar a esta región, se realizan movimientos circulares para estimular los nudos linfáticos. El masaje depende de la característica que predomine: espasticidad o pareticidad. En los casos de pareticidad se pasa de los movimientos suaves a los fuertes y en los casos de espasticidad, los movimientos siempre deben ser suaves.

4. **Desarrollo de la respiración fisiológica y la respiración en función del habla:** Es necesario enseñar al niño a realizar una inspiración profunda lenta y moderada, por ejemplo: inspiración nasal amplia, espiración suave en la misma forma; inspiración nasal profunda, espiración lenta y prolongada.

Estos ejercicios pueden acompañarse de movimientos corporales, por ejemplo inspiración nasal lenta, llevando los brazos hacia arriba, espiración bucal lenta, llevando las manos hacia abajo. Esta espiración puede ser silente o sonora, emitiendo un sonido que se alargue.

5. **Trabajo con las cualidades de la voz (entonación-ritmo-timbre).** Por ejemplo: pronunciar de forma alargada la vocal “a”; aumentar la intensidad vocal; inspiración profunda y durante la espiración que debe ser prolongada, se pronuncian combinaciones silábicas.

6. **Desarrollo del componente del lenguaje**: De acuerdo con la etapa en que se encuentre: componente fónico, léxico, gramatical o pragmático de la lengua, se seleccionan las actividades para el tratamiento.

7. **Desarrollo de la coordinación motriz** (control muscular): Para la realización de estos ejercicios se ponen en práctica el empleo de los analizadores conservados, en este caso, la vista, el tacto y la audición. Por ejemplo: puntear figuras, resolver laberintos sencillos, amasar plastilina, colorear figuras geométricas, diferenciar sonidos; entre otros.

8. **Desarrollo de la motricidad general**: las acciones que se pueden desarrollar están sobre la base de la ejercitación de los músculos que intervienen en la motórica gruesa. Por ejemplo: parase en un solo pie, caminar sobre una línea trazada en el piso, marchar al compás de la música, saltar en el mismo lugar.

9. **Trabajo con el desarrollo de los procesos psíquicos:** En este aspecto, se pone en práctica de manera abarcadora y directa uno de los postulados de Vygotsky (Zona de Desarrollo Próximo), determinado por la capacidad que puede tener el escolar de resolver por sí solo el rompecabezas o si necesita la mediación del especialista o de otros niños más capaces. Por ejemplo: presentación de láminas para preguntarles ¿Quién es? o ¿Qué es? ¿Todos juntos qué son? Repetir series de figuras geométricas. El Cuarto excluido.

10**. Desarrollo de la motricidad articulatoria**. Los ejercicios gimnásticos para la lengua y labios; como por ejemplo sacar y entrar la lengua, primeramente en forma lenta, después más rápido, imitando al gatico cuando toma leche; extensión de las comisuras labiales imitando una sonrisa, entre otros.

Los ejercicios anteriores están dirigidos a potenciar el desarrollo de un escolar disártrico. Como se puede apreciar el tratamiento logopédico en casos de disartria es largo y complejo, exige de un trabajo en equipo (neurólogo, pediatra, oftalmólogo, ortopédico, psicólogo, logopeda).

Esta investigación se dirige a elaborar una estrategia didáctica la cual va a enriquecer la rehabilitación logopédica del niño portador de disartria con el empleo de la terapia ocupacional en el área de las Actividades de la vida diaria para el desarrollo del componente del lenguaje por lo que el maestro logopeda debe realizar un trabajo permanente y durante la exploración es necesario determinar el carácter del trastorno en la esfera de la motricidad. Se han de crear hábitos motores correctos, eliminar la espasticidad, disminuir las hipercinesias y la debilidad muscular, desarrollar la movilidad de los dedos y de las extremidades, así como el control muscular.

En el desarrollo de la motricidad articulatoria se ha de enfatizar en la utilización de los movimientos involuntarios, el masaje de los órganos articulatorios, la gimnasia pasiva con cambio palatino a la activa. Otro aspecto de particular interés, está relacionado con los masajes de los órganos articulatorios, los que pueden aplicarse en los labios, la lengua, el cuello, las mejillas y el velo. Su objetivo es activar o inhibir los movimientos de determinado órgano.

Las limitaciones físico-motoras constituyen una de las principales discapacidades que afectan a la población mundial. En Cuba, el estudio psicosocial de las personas con discapacidad, realizado en todo el territorio nacional en el año 2003 por orientación del Comandante en Jefe Fidel Castro, reveló que las limitaciones físico-motoras ocupan el segundo lugar entre todas las discapacidades con un total de 92506 afectados, superado sólo por los portadores de retraso mental.

Esta cifra puede ser superior si se toma en cuenta que muchas de las personas con retraso mental y otras discapacidades también presentan algún nivel de limitación en su desempeño motor. La conceptualización de las limitaciones físico-motoras es un asunto complejo, que por su connotación, involucra a especialistas de las más variadas disciplinas científicas y técnicas, entre ellos a médicos, psicólogos, pedagogos, sociólogos, arquitectos, etc.

Una definición desde la perspectiva psicopedagógica podría resumirse de la siguiente manera:

Limitado físico-motor es toda persona que presenta de manera transitoria o permanente una alteración en su desempeño motor debido al deficiente funcionamiento del sistema osteomioarticular y/o nervioso que limita en grado variable la realización algunas de las actividades propias de su grupo etáreo, pudiendo o no presentar agravantes de tipo sensorial o intelectual.

Para la cabal comprensión de la definición es necesario profundizar en cada uno de los atributos que la conforman:

- En estas personas está afectado primariamente el desempeño motor. En muchos casos, las dificultades en la ejecución de los movimientos o la ausencia de estos pueden conducir a interpretaciones erróneas respecto a las capacidades intelectuales de estos

sujetos, los que pueden ser tratados como retrasados mentales, basándose sólo en sus manifestaciones externas.

La alteración en el desempeño motor puede ser transitoria o permanente. Se trata de un estado físico determinado que en muchos casos se presenta transitoriamente por períodos relativamente cortos; pero aún en aquellos casos donde la afectación es permanente, este puede mejorar sustancialmente con una adecuada intervención clínica y psicopedagógica.

- Se limita en grado variable la realización de algunas actividades. No se debe incurrir en generalizaciones, porque se pueden encontrar diferencias en las capacidades funcionales de cada sujeto aun cuando la patología de base sea la misma. Por otra parte las limitaciones comúnmente no son tantas como a primera vista nos parece. Esto está motivado fundamentalmente por el bajo nivel de expectativas de los adultos (padres, maestros, etc.) con respecto a las potencialidades de estos para interactuar con su medio ambiente; es posible que pueda hacer lo mismo que los demás, solo que de manera diferente.

Clasificación

Las limitaciones físico motoras pueden ser agrupadas atendiendo a diferentes criterios de clasificación:

_ Según el momento de aparición de la enfermedad de origen.

_ Según el grado de toma motora.

_ Topográfica

Según el momento de aparición

Según esta clasificación las limitaciones físico-motoras se clasifican en prenatales, perinatales y postnatales.

Las prenatales son aquellas que tienen su origen antes del nacimiento. Es en este período donde se producen los más trascendentales cambios anatomofisiológicos que posibilitan la transformación del minúsculo huevo o cigoto en un individuo completamente formado, en el corto lapso de 9 meses.

El crecimiento y desarrollo intrauterino estará determinado por la información genética heredada de sus padres y la existencia de condiciones favorables en el claustro materno. La herencia, los déficits nutricionales, enfermedades crónicas e infecciones padecidas

por las gestantes, entre otros, son factores potencialmente generadores de malformaciones congénitas que pueden producir limitaciones físico-motoras, como son los casos de Espina bífida, Artrogriposis, miopatías, amelias, focomelias, etc. Las perinatales están relacionadas con el momento del nacimiento; entre las principales causas se encuentran los partos demorados con versiones y extracciones, que pueden provocar al recién nacido traumatismos craneocefálicos y vertebrales, anoxias, etc. Las postnatales se originan después del nacimiento como resultado de accidentes (traumatismos, quemaduras, amputaciones, etc.), infecciones (Poliomielitis, Tuberculosis ósea, etc.), entre otras.

Según el grado de toma motora

Estas se agrupan en tres categorías:

Leve: cuando el individuo deambula solo sin apoyo pero con dificultad; está afectada la capacidad coordinativa, el equilibrio y las relaciones témporo-espaciales. El autovalidismo está conservado.

Moderada: deambula con apoyo (muletas, andadores, silla de rueda). Está afectada la motricidad fina y gruesa y el autovalidismo es limitado.

Severa: no deambula ni con apoyo y el autovalidismo está seriamente afectado.

Clasificación topográfica

Se refiere a la parte del cuerpo donde se manifiesta el déficit motor ya sea en la variante paresia o plejía.

Paresia: cuando la afectación motora se manifiesta en debilidad muscular (se afecta el componente fuerza), aunque existen casos en que esta permanece intacta provocando fundamentalmente insuficiencia en la precisión y la calidad del movimiento, especialmente cuando se carece de la aferentación cinestésica.

Plejía: es el grado superior de afectación de la función motora expresada en una verdadera parálisis muscular, con poca o ninguna movilidad.

Las paresias o plejías se clasifican, según su localización topográfica en:

Tetraplejía o tetraparesia: cuando están afectadas las cuatro extremidades.

Triplejía o triparesia: están afectadas tres de las cuatro extremidades; con más frecuencia el miembro intacto pertenece al tren motor superior.

Hemiplejía o hemiparesia: se afecta la función motora de un hemicuerpo (derecho o izquierdo).

Diplejía o diparesia: se define como déficit motor de las cuatro extremidades, con menor afectación en el tren motor superior.

Monoplejía o monoparesia: el déficit motor está localizado en uno solo miembro.

Muchas son las causas que provocan limitaciones físico –motoras en los niños, las cuales se pueden comportar de modo diferente en cada región geográfica, países e incluso en distintos territorios de un mismo país; sin embargo las estadísticas de los organismos internacionales recogen un grupo de entidades que con mayor frecuencia inciden en esta discapacidad. A continuación detallaremos la que más repercute en las alteraciones del lenguaje:

Disfunción cerebral infantil. Conocida también como Parálisis Cerebral Infantil es una entidad constituida por una alteración no progresiva de la función motora, debido a una lesión estática del sistema nervioso central de etiología pre, peri y postnatal, antes de la maduración de este, que se expresa en un trastorno del control motor, del tono muscular y del movimiento, que puede estar acompañada de afectaciones sensoriales, del intelecto, crisis convulsivas y afectaciones del lenguaje. Esta enfermedad descrita por Little en 1843, quien reveló su relación con la anoxia neonatal, es hoy en día una entidad bien conocida aunque aún quedan elementos donde se hace necesario profundizar.

Muchas son las causas que devienen en esta entidad. En el período prenatal se destacan las de origen genético, las infecciones, la desnutrición materna y las anoxias asociadas a la hipotensión materna y la toxemia grávida, entre otras. Dentro de las causas se encuentran también las relacionadas con el momento del parto, como placenta previa, la administración de anestesia a la madre, la hipotensión arterial de esta, que pueden provocar anoxia en el recién nacido. Otras de las causas de parálisis cerebral en esta etapa son los traumatismos provocados durante el trabajo de parto.

En la etapa postnatal las causas principales son las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central y los traumatismos. Múltiples son las clasificaciones propuestas y utilizadas por los especialistas durante más de cien años y diversos los criterios empleados, pero en general se distinguen cuatro tipos: Espástica, Atetósica, Atáxica y Mixta.

Espástica: Es la forma más común de las parálisis cerebrales, caracterizadas por un elevado tono muscular (hipertonía), y sus manifestaciones iniciales son la hiperreflexia y la persistencia anormal de los reflejos neonatales. Se debe a una lesión en la corteza motora y las fibras del sistema piramidal. Su nivel de afectación y su extensión topográfica está determinado por la cantidad de fibras involucradas en el daño y el lugar donde este se produce (Puentes, 2005, p. 119).

El aumento del tono muscular puede provocar rigidez de los grupos musculares afectados produciendo contracturas y graves interferencias en el movimiento y en la postura. Las parálisis espásticas se manifiestan preferentemente en forma de hemiplejía, tetraplejía y diplejía. La espasticidad suele afectar a los músculos flexores de las extremidades superiores y a los extensores de las extremidades inferiores.

Atetósica: También conocida como extrapiramidal. Es el resultado una lesión en este sistema, fundamentalmente al nivel de los núcleos grises centrales del cerebro, provocando movimientos involuntarios lentos y torcidos, o repentinos y rápidos, de los pies, brazos, manos o músculos de la cara.

Estas reacciones involuntarias interfieren en la realización de los actos motrices voluntarios. El tono muscular es variable lo que repercute en dificultades para mantener la postura, la precisión de los movimientos y en situación de excitación, el aumento de las estereotipias. La mayoría de los niños que la padecen son de inteligencia normal, pero al tener afectada la musculatura vinculada a la producción del lenguaje, les resulta difícil la comunicación. Este trastorno logopédico es conocido como disartria.

Atáxica: Es una forma rara de disfunción cerebral. En la lactancia se aprecia hipotonía y los reflejos osteotendinosos son hipoactivos. Por lo general hacia el segundo año se aprecia el temblor intencional y la marcha atáxica. Su origen está en una lesión en los núcleos grises centrales del cerebelo y/o las vías de aferencia y eferencia con otros centros nerviosos. Están afectados el equilibrio, la coordinación de los movimientos, especialmente los rápidos y precisos, y el lenguaje.

Mixta: Es la más frecuente y compleja de las parálisis cerebrales, que reúne en sí formas hipotónicas (flácidas) e hipertónicas (espásticas) con variantes

Tónico- clónicas y parecen más propias de lesiones poco localizadas con compromiso tanto de vías piramidales como extrapiramidales.

Hipotónica o flácida: Es típica de las parálisis periféricas que afectan las astas anteriores (motoras) de la médula espinal o de los troncos nerviosos periféricos y se manifiesta en un descenso marcado del tono muscular (hipotonía) y la abolición de los reflejos profundos y superficiales.

El pronóstico de desarrollo de un niño con disfunción cerebral infantil depende sobre todo de la existencia y severidad de déficit intelectual. Buenos resultados se pueden obtener en déficit motores severos si la capacidad intelectual es buena.

La atención logopédica a los alumnos con limitaciones físico-motoras:

Es una tarea compleja que requiere la adopción de distintas alternativas para dar la cobertura educativa requerida a cada caso en correspondencia con sus necesidades y potencialidades. En nuestro país están establecidas cuatro modalidades para la atención educativa dentro de esta la rehabilitación: la escuela común, la escuela especial, aulas hospitalarias y la atención en sus hogares por maestros ambulantes, de modo que cada uno reciba los beneficios de la educación en las condiciones que mejor se ajusten a sus necesidades y posibilidades. La mayoría de los alumnos con limitaciones físico-motoras pueden asistir regularmente a la escuela común o la escuela especial, en los casos en que se requiera la atención logopédica especializada relacionada con trastornos del lenguaje, insuficiencias sensoriales y otras. Para atender a los alumnos, que por razones de salud relacionadas con su estatus físico y/o neurológico requieren largos períodos de hospitalización, existen las aulas hospitalarias donde reciben la atención pedagógica y logopédica necesaria durante el tránsito por estas unidades de salud.

Existe otro grupo de niños y adolescentes que por diversas razones deben recibir cobertura educativa en sus propios hogares, donde son atendidos por maestros ambulantes y otros especialistas de la educación especial entre ellos el logopeda. Cualquiera que sea la modalidad de atención logopédica a la que esté sujeto el alumno esta debe cubrir a la familia y el entorno comunitario, donde la escuela y el maestro logopeda juegan un papel dinamizador de la interacción de los tres factores en función de la preparación del alumno para el desarrollo de la comunicación oral y la integración social plena.

La intervención logopédica integral no debe ser concebida desde una perspectiva netamente curricular, centrada en el trabajo directo con el alumno, sino muy

singularmente como un sistema de acciones armónicamente estructuradas que involucre a la familia y los demás agentes y agencias comunitarias en función de la labor educativa que realiza la escuela y el maestro logopeda. Son estos últimos los encargados de proyectar y darle la coherencia y sistematicidad necesaria al sistema de influencias educativas; desde esa perspectiva la escuela como centro rector de la labor La estructuración adecuada de la intervención logopédica requiere del logopeda un profundo conocimiento de las características del estado físico de sus alumnos, así como las particularidades del lenguaje, características, fisiológicas, psicológicas y pedagógicas de estos y de su entorno.

El niño con limitaciones físico-motoras necesita adaptaciones curriculares significativas en varias áreas del currículo que le corresponde a su edad, lo que no implica que no haya alcanzado en lo fundamental el desarrollo de las capacidades y habilidades comunicativas y pedagógicas necesarias en correspondencia con el grado en que se encuentra. Esto es posible cuando se logra la mayor participación de los alumnos en el currículo oficial, donde se le dé especial atención a las necesidades.

La rehabilitación física, psicológica y logopédica llevada al plano de la práctica logopédica con los alumnos con limitaciones físico-motoras se traduce en el desarrollo del autovalidismo, la preparación socio laboral, la estimulación de la actividad física y la comunicación en general así como de la socialización, en función de la preparación para la vida adulta independiente.

Desde el punto de vista de la práctica educativa la rehabilitación logopédica a escolares con disartria, concebida desde la clínica y la terapéutica, es asumida por la educación motora. No se trata de suplir la labor de fisiatras, terapistas ocupacionales y otros especialistas de la salud, sino muy singularmente de convertir a la escuela en escenario donde la rehabilitación encuentre su continuidad y en el logopeda un promotor.

Otra característica que presentan los escolares con discapacidad físico motora es la disminución de la capacidad para la realización de las actividades de la vida diaria por lo que resulta necesario el desarrollo y aplicación del programa de terapia ocupacional en la mayoría de sus casos la terapia ocupacional es una ciencia que se dirige principalmente a la rehabilitación y habilitación de personas que han visto alteradas sus capacidades para desenvolverse normalmente (a nivel físico y/o intelectual) como

consecuencia de problemas en el desarrollo de las personas, del proceso de envejecimiento, de enfermedades mentales o problemas emocionales. Los objetivos de la terapia ocupacional son conseguir y alcanzar, el mayor grado de independencia posible en las personas, a través de las actividades terapéuticas.

La terapia ocupacional ve al hombre como un ser biopsicosocial, y lo ayuda a adquirir o recuperar habilidades dañadas o perdidas por cualquier causa, para insertarlo a la sociedad.

El desarrollo del autovalidismo es un aspecto importante a desarrollar dentro de las Escuelas para niños con discapacidad físico motora ya que son las acciones que el individuo realiza en función de resolver necesidades básicas como: lograr adquirir un buen equilibrio para desplazarse hacia cualquier parte, bañarse, vestirse, desvestirse, alimentarse, y la posibilidad de relacionarse y resolver sus problemas sociales de forma independiente, teniendo en cuenta que los escolares de nuestro centro presentan como defecto primario dificultades en la actividad motriz que les limita caminar, correr saltar, trasladarse en diferentes direcciones, manipular objetos, realizar movimientos pre articulatorios para el lenguaje, masticar, tragar y por tanto comunicarse.

La Terapia ocupacional la cual cuenta con una visión histórica donde el antecedente más remoto de la profesión, al parecer, se conecta con el psiquiatra francés Philip Pinel (1745-1826), quien en 1793 liberó a los "locos" de sus cadenas y fue un ferviente defensor del "tratamiento moral" de esos pacientes en oposición a la corriente represora y disciplinaria. El "tratamiento moral" del enfermo se caracterizó por dispensarle una vida en un ambiente saludable, con el desarrollo de hábitos sociales beneficiosos, una alimentación apropiada y una actividad adecuada y organizada (Duran Noya, 2009). Pinel consideraba a la ocupación como un elemento central en la concepción del "tratamiento moral". Introdujo el empleo de actividades como la música, la literatura, el ejercicio físico y el trabajo. Este enfoque pasó a formar parte del programa terapéutico de las instituciones psiquiátricas de la época con la condición expresa de que fuera del gusto del paciente.

A pesar de que los conceptos que sustentan la terapia ocupacional hoy día tienen sus raíces en la antigüedad no fue, precisamente, hasta comienzos del siglo XX que se estableciera la profesión como tal. A lo largo de la evolución de la misma se ha sostenido la creencia de que estar ocupado es fundamental para establecer, conservar y restaurar

la salud, así como el principio de considerar a cada persona como un ser individual con necesidades específicas. Esta disciplina se encarga por sobre todas las cosas del cuidado de la salud.

En 1968 quedó definida por la Asociación Americana de Terapia Ocupacional como la actividad designada para dar respuesta el hombre a diligencias. La visión holística de la persona permite a los profesionales de esta especialidad acercarse a los pacientes de una manera muy particular, teniendo en cuenta las características personales, su entorno, su historia, sus motivaciones. Seleccionada para favorecer y mantener la salud, para prevenir la incapacidad, para valorar la conducta y para tratar o adiestrar a los pacientes con disfunciones físicas o psicosociales.

Según Gómez Tolón (1999) es el arte y la ciencia de dirigir la respuesta del paciente en la realización de la actividad intencionada hacia objetivos específicos, previamente analizada y seleccionada en función de las necesidades del enfermo, incapacitado o marginado y con fines de evaluación, prevención, adiestramiento, reeducación, tratamiento y reinserción tendentes a conseguir el máximo grado de autonomía con el mínimo de alienación posible para conseguir una equilibrada adaptación al medio (Sánchez Valdés, 2017).

> Navarro Quintero (2006), expresa que se entiende por limitaciones físico-motoras: “aquellas que provocan imposibilidad o disminución para realizar las actividades motoras propias de un grupo etáreo de manera permanente o transitoria, debido a la ausencia o insuficiente funcionamiento de los sistemas óseo-mio-articular y/o nervioso. “Pueden combinarse con alteraciones emocionales, intelectuales, sensoriales, del lenguaje, u otras. Los factores causales son diversos y surgen en cualquier período de la vida” (p. 60)

El investigador español Jorge Gutiérrez Ayala (2008) plantea que la terapia ocupacional es una carrera universitaria, del área de las ciencias de la salud, que se dirige principalmente a la rehabilitación y habilitación de personas que han visto alteradas sus capacidades para desenvolverse normalmente (a nivel físico y/o intelectual) como consecuencia de problemas en el desarrollo de las personas, del proceso de envejecimiento, de enfermedades mentales o problemas emocionales. Los objetivos de

la terapia ocupacional son conseguir y alcanzar, el mayor grado de independencia posible en las personas, a través de las actividades terapéuticas.

La terapia ocupacional es una ciencia que ve al hombre como un ser biopsicosocial, y lo ayuda a adquirir o recuperar habilidades dañadas o perdidas por cualquier causa, para insertarlo a la sociedad. La teoría del comportamiento ocupacional nos permite comprender al ser humano como un ser ocupacional, que participa todo el tiempo en ocupaciones, que llenan de significado su vida, permite cubrir necesidades de mantenimiento personal, expresión y logro. Con el uso terapéutico de estas ocupaciones, se puede impactar en la calidad de vida y el bienestar (Duran Noya, 2009)

Esta ciencia permite analizar las áreas de desempeño (AVD-B e I, actividades productivas y actividades de ocio y juego), las habilidades del desempeño (motoras, sensoriales y praxis, de procesamiento y de regulación emocional) y los contextos de la ejecución (aspectos temporales y ambientales). Como elemento central analiza el desempeño ocupacional, entendido como la capacidad para ejecutar aquellas tareas que hacen posible desarrollar los roles ocupacionales de manera satisfactoria y apropiada en relación con: edad del individuo, cultura y entorno. “El desempeño ocupacional requiere aprendizaje y experiencia en la realización del rol, un nivel de desarrollo específico para el desempeño de las tareas y la utilización de todos los componentes de la ejecución” (Mesa Leon & Palacios Mazabel, 2013, p. 35). Por el contrario los déficits en las experiencias de aprendizaje, de las habilidades de desempeño y/o del espacio vital, pueden producir limitaciones en el desempeño ocupacional.

El trabajo del Terapeuta Ocupacional consiste, en ayudar a alcanzar la máxima independencia posible en las áreas de desempeño ocupacional y a reasumir o proponer roles. Plantea un continuum terapéutico, en el cual las etapas del tratamiento se solapan o se dan simultáneamente. Este continuum no sigue una progresión escalonada estrictamente, sino que sigue una progresión lógica que va desde la dependencia en la actividad hasta la reasunción de los roles vitales. Las etapas son las siguientes: (1) métodos preparativos para la actividad; (2) métodos facilitadores y coadyuvantes, (3) actividad propositiva y por último (4) desempeño ocupacional y roles ocupacionales. Con estas acciones se espera generar un dominio de la actividad, donde la persona sea eficaz

en el uso de su tiempo, energía y recursos, lograr los objetivos que desea y obtenga una respuesta de aprobación de su medio cercano.

El trabajo con las actividades de la vida diaria forma parte del trabajo del terapista ocupacional área que será desarrollada en esta investigación en función de rehabilitar el lenguaje en escolares con disartria de la Escuela Especial Amistad Cuba Vietnam. Las actividades de la vida diaria son el conjunto de técnicas compensatorias que le permitirán a la persona con discapacidad físico motora desenvolverse con eficiencia en diversas tareas de la vida cotidiana, exige desde las labores más sencillas de aseo personal hasta la preparación exquisita de diversos alimentos. Tiene como objetivo fundamental lograr que las personas con discapacidad físico motora dominen y apliquen las técnicas de terapia ocupacional y de este modo realicen con eficiencia las actividades que la vida cotidiana exige mejorando su integración social y laboral.

El trabajo compensatorio en esta actividad lo constituye la enseñanza de diferentes técnicas que lo ayuden en su independencia y desenvolvimiento personal, social y verbal en función de adquirir además un mejor desarrollo de la comunicación oral y el logro de una independencia verbal en los casos de escolares portadores de disartria. Dividiendo el tratamiento en sub áreas según demanda el programa de terapia ocupacional que incluye:

Atención y cuidado personal, desvestirse, vestirse, arreglo personal.

Medio familiar: higiene y arreglo de la casa, lavado y planchado, cocina básica, costura básica.

Medio social: Comportamiento en la mesa, comunicación, hora, manejo del teléfono, tramites, conducta social, saludo, postura, gestos, iniciación de conversaciones.

Las técnicas compensatorias que se imparten en este departamento son importantes dentro del programa de rehabilitación funcional que permiten a las personas con discapacidad físico motora desarrollar habilidades para conocer, identificar y realizar actividades en el contexto cotidiano, brindando un entrenamiento especializado de sus capacidades físicas y los miembros conservados, además de estimular las funciones superiores como: lenguaje, atención, memoria y creatividad. Logrando así sus máximas habilidades y destrezas a través de la realización de actividades y proyectos productivos.

2- Antecedentes históricos que han caracterizado la atención a escolares con discapacidad físico motora que presentan dificultades en el lenguaje.

La atención educativa a las personas con Discapacidad físico-motoras se realiza a través de diferentes modalidades, entre las que se encuentran:

• **El aula hospitalaria, creada en el período comprendido de 1945 a 1958**; la primera de este tipo se abrió en el actual Hospital Docente Manuel Fajardo de La Habana. •

La enseñanza ambulatoria (maestros ambulantes), hoy conocidos como maestros de apoyo, modalidad creada a partir de 1985 para aquellos que no pueden asistir a la institución escolar correspondiente hasta la actualidad.

• **Las Escuelas Especiales para niños con discapacidad físico motoras**, nuestro país en la actualidad cuenta con tres escuelas de carácter nacional. Solidaridad con Panamá; la primera escuela y única en Cuba por aquel entonces fue creada en La Habana el 31 de diciembre de 1989, hasta el 23 de abril del 2019 que se inaugura en la provincia de Santiago de Cuba la segunda escuela para la atención a esta Discapacidad y de igual forma el 3 de septiembre del mismo año queda inaugurada la Escuela Especial Marta Abreu en la provincia de Villa Clara.

• La escuela regular cubana, abierta a la diversidad, para la inclusión educativa de los alumnos con Discapacidad físico-motoras.

La historia de la atención educativa de estas personas ha sido sistematizada en cuatro etapas fundamentales:

1. Etapa. Primeros intentos (1902-1958). Aulas hospitalarias La atención educativa a las personas con Discapacidad físico-motoras en esta etapa se redujo a la enseñanza de un oficio para los hombres mayores de 20 años que residían en Ciudad de La Habana. En el año 1944 se extiende la atención a niños de ambos sexos mayores de 12 años y se combina la rehabilitación física con la enseñanza de un oficio. En 1948 se inaugura el Instituto de Cirugía Ortopédica, y en él, la Escuela Pública No. 121, donde se ofrece atención educativa a los niños de ambos sexos, mayores de 12 años. La iniciativa de crear la escuela responde a Carmelina Virgilí, quien condujo, a través de tres aulas, la enseñanza de un oficio y del autovalidismo a los beneficiados con esta atención. Entre los años 1945 y 1958 se inicia la primera modalidad para la atención educativa: las aulas hospitalarias, término propuesto por Carmelina Virgilí en el año 1945, que mantiene su

vigencia. La primera de este tipo se abrió en el Hospital Reina Mercedes, suceso que marcó el inicio de la educación para los hospitalizados en edad escolar. Las personas con Discapacidad físico-motoras pertenecientes a las clases medias y pobres eran prácticamente ignoradas y sin oportunidad de integración a la vida social. El enfoque esencialmente clínico del diagnóstico se centraba en las dificultades, desde la tendencia de la atención asistencial y el predominio de un enfoque clínico-pedagógico con la influencia de concepciones religiosas (Navarro Quintero, 2006).

2. Etapa. Organización de la Atención Educativa (1959-1989). Maestro Ambulante

En esta etapa se amplía el servicio con seis aulas hospitalarias más. Se inaugura en La Habana la primera escuela para niños, adolescentes y jóvenes con limitaciones físico-motoras Fructuoso Rodríguez, donde labora un equipo multidisciplinario compuesto por médicos y pedagogos que atendían 58 niños. En el año 1968 la escuela deja de funcionar, momento a partir del cual se produce un período de estancamiento en la Somatopedia cubana y Carmelina Virgilí deja de dirigir esta educación.

En el curso escolar 1975-1976, se introduce el plan de perfeccionamiento y tránsito hacia una nueva estructura y un nuevo contenido de la educación; se destaca el papel de la pedagogía como ciencia en la solución de problemas teóricos y prácticos. La ampliación del principio de normalización y la irrupción del concepto de Necesidades Educativas Especiales (Informe de Warnock, 1978) compulsan la reconceptualización de la Educación Especial en la década del 80, a partir de lo cual se renuevan concepciones, conceptos, métodos y estilos de trabajo y se amplía el universo, las modalidades de atención, los servicios y su calidad. En 1980 se constituye oficialmente la Asociación Cubana de Limitados Físicos y Motores, (ACLIFIM)[1], aunque desde 1976 un grupo de personas con limitaciones físico-motoras se esfuerza activamente por impulsar acciones sociales.

En enero de 1985 se crea una nueva modalidad para la atención educativa de los alumnos con limitaciones físico-motoras entre 5 y 16 años de edad. Se dicta por el

[1] Esta Asociación tiene una estructura orgánica bien definida, dirigida (a nivel central y en cada territorio) por personas discapacitadas elegidas democráticamente por su membresía. Sus miembros tienen una activa participación en eventos deportivos, recreativos, culturales y sociales a nivel nacional e internacional.

Ministerio de Educación la Resolución No.13[2] que establece la educación en el hogar por maestros ambulantes para aquellos que no pueden asistir a la institución escolar que les corresponde. El 31 de diciembre de 1989 se inaugura en La Habana la Escuela Especial Solidaridad con Panamá, con carácter nacional y única hasta el momento para la atención de alumnos con limitaciones físico-motoras. Se incluye en el plan de estudios de la carrera de la licenciatura en Educación Especial, a través de las disciplinas Psicología, Pedagogía, Logopedia, la preparación de los futuros profesionales para el trabajo con niños, adolescentes y jóvenes que presentan Discapacidad físico-motoras y sus familias. Se instrumentan cursos de postgrado y entrenamiento en hospitales de rehabilitación para los trabajadores del centro y se estrechan vínculos con maestros ambulantes y hospitalarios. A partir del trabajo desarrollado, los avances de la pedagogía especial y la política trazada por el Estado, se inicia una etapa cualitativamente superior, que permite una mejor integración de estas personas a la sociedad.

3. Etapa. Ampliación y perfeccionamiento de la atención educativa (1990 al 2018)

La escuela nacional Solidaridad con Panamá Se celebra el Primer Congreso de la ACLIFIM y se extienden los servicios de los maestros ambulantes a las casas de los adultos que así lo requieren, de modo que todas las personas con Discapacidad físico-motoras logren alcanzar el nivel primario y secundario según sus posibilidades. Se reinicia la modalidad de atención por medio de la escuela especial con la inauguración de la escuela Solidaridad con Panamá. La colaboración del asesor alemán Helmut Berndt[3] fue de gran utilidad para la preparación de los directivos a todas las instancias, de los futuros trabajadores docentes y no docentes y del personal médico y paramédico que laboraría en la escuela, así como en la elaboración de la bibliografía especializada y los documentos necesarios para normar y crear las condiciones para el buen funcionamiento de la institución.

En la formación del personal docente, no se contaba con la especialización en los contenidos de la Somatopedia, lo que trajo como consecuencia que la preparación de los egresados de los planes de estudio Ay B, para el trabajo con los alumnos con

[2] La Resolución Ministerial13/85, plantea el asesoramiento por parte de la escuela especial más cercana a los alumnos que por diversas razones no pueden asistir a la misma.

[3] Profesor del Instituto Especial de la Universidad de Humboldt, de Berlín y alumno del Dr. Peter Voig (precursor de la Somatopedia en el mundo).

discapacidad físico-motora fuera limitada. La temática se abordaba con poca profundidad en la asignatura Introducción a la Especialidad, por lo que el conocimiento sobre el trabajo de atención integral que requieren estos alumnos, no era suficiente. En el año 1990 se crea el Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial (CELAEE), institución a la que se adscriben algunas escuelas especiales como laboratorios de investigación; Solidaridad con Panamá, fue una de ellas, que ayudó a solucionar las principales problemáticas que se enfrentaban por la vía científica.

En 1991 se declara el proceso de perfeccionamiento de la Educación Especial, la municipalización de los Centros de Diagnóstico y Orientación, la apertura de la carrera de Defectología en otras provincias del país y la implementación del nuevo plan de estudio C, lo que, unido a los estudios de superación de los egresados, implicaron transformaciones positivas en el trabajo con estos alumnos. Los activos ACLIFIM–MINED[4], son importantes fuentes para la evaluación de la actividad que se realiza y las problemáticas a resolver. Como resultado del análisis realizado en el activo celebrado en el año 2003, se instituye la Circular sobre Profesor de Apoyo para alumnos con Discapacidad físico-motoras[5].

En esta etapa es trascendental el acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, con fecha 17 de Octubre de 2006, que legaliza la puesta en vigor del actual Plan de Acción Nacional para la atención a las personas con discapacidad, donde se refleja la prioridad concedida a la educación de estas personas en el medio más normalizador posible. La política del estado, la aplicación de los postulados de la escuela vigotskiana, las raíces marxistas y martianas, ajustadas al contexto actual, son pilares que sustentan hoy la pedagogía especial cubana, donde se prioriza la unificación de esfuerzos y la proyección de estrategias que garanticen la inclusión social de estas personas, en importantes direcciones tales como: la continua preparación de los comprometidos con la atención educativa, la creación de condiciones en las instituciones escolares para la

[4] Reunión Nacional dirigida de conjunto por la Dirección de Educación Especial del MINED y la ACLIFIM Nacional, donde participan los metodólogos provinciales y activistas de la ACLIFIM de la esfera de Educación, para analizar los resultados alcanzados, las principales problemáticas, proponer soluciones y proyectar el trabajo futuro.

[5] En esta circular se establece el incremento de plazas para la educación especial en la especialidad de limitaciones físico-motores, a partir del curso escolar 2003-2004, como soporte para el cumplimiento de una de las prioridades de la enseñanza y consiste en la ubicación de un maestro de apoyo para los alumnos con limitaciones físico-motoras severas integrados a la enseñanza general.

eliminación de barreras, el uso óptimo de los Programas de la Revolución desde el trabajo correctivo-compensatorio.

El proceso de evaluación y diagnóstico, así como la estrategia de atención integral debe basarse en una posición optimista y desarrolladora. Cuando un niño o adolescente ingresa en la escuela especial se le conforma un expediente psicopedagógico que incluye los resúmenes clínicos de las evaluaciones realizadas por los diferentes especialistas. En dicho expediente se registran los datos anamnésicos, los resultados de pruebas psicológicas, psicométricas, pedagógicas y sociológicas aplicadas por los especialistas del CDO y particularmente un informe psicopedagógico, elaborado por el maestro ambulante en el caso que haya recibido alguna escolarización en esta modalidad. Le compete a la comisión de apoyo al diagnóstico de la escuela especial enriquecer, actualizar, contextualizar y perfeccionar el diagnóstico y la caracterización psicopedagógica.

4. Etapa - (2019-2023) Ampliación de la atención a educandos con discapacidad físico motora a través de la creación de dos nuevas escuelas para la atención educativa y terapéutica a esta especialidad.

En el año 2019 dando cumplimiento a un sueño de nuestro comandante en jefe y líder histórico de la Revolución Fidel Castro Ruz se inauguran en nuestro país dos escuelas para la atención educativa a escolares con discapacidad físico motora por el general de ejército Raúl castro Ruz y el primer secretario del partido Miguel Díaz Canel Vermúdez. La primera escuela fundada el 23 de abril del 2019 en la provincia de Santiago de cuba Aglutina en si Escolares de las cinco provincias orientales: Holguín, Las Tunas, Granma, Santiago de cuba y Guantánamo, la misma cuenta con 32 docentes y una veintena de auxiliares pedagógicos, dos logopedas, psicólogo, psicopedagogo, bibliotecarias y otro personal especializado en esta enseñanza que transita desde 5 a los 15 años en los niveles de enseñanza preescolar, primaria y secundaria básica.

La atención a estos educandos incluyen servicio de rehabilitación física y la atención especializada de un equipo multidisciplinario entre los que se incluye la atención logopédica integral para los cuales cuentan con, gabinete logopédico, aulas, laboratorios, áreas de juego, gimnasio, talleres de preparación laboral, consultorio médico, salón de estomatología, electroterapia y magnetoterapia además de contar con grandes espacios

abiertos y muchos árboles que permiten la interacción de los escolares con el medio ambiente y la naturaleza.

Entre los propósitos de la institución figuran la rehabilitación física, psicopedagógica y logopédica de los educandos en relación con el diagnostico que presentan y el objetivo del nivel educativo que le corresponde para garantizar la continuidad de estudios, además se propone lograr el máximo desarrollo integral posible de las personas con necesidades educativas especiales en cualquier contexto educativo, que les permita enfrentar con diversos niveles de independencia su inclusión social.

Misión: Lograr la integración social, plena y feliz de los educandos con discapacidad físico- motoras, a partir de la potenciación de sus capacidades y para lograrlo es necesario:

- Asistir a los educandos en el aspecto clínico, sanitario y estomatológico.
- Lograr la habilitación o rehabilitación física.
- Garantizar la formación cultural y laboral básica en correspondencia con los principios de nuestra política educacional.
- Lograr la rehabilitación psicológica.
- Lograr un adecuado desarrollo del lenguaje, el vocabulario y la expresión oral como parte del proceso de atención logopédica.

Visión:

Transitar a la Enseñanza General al total de los alumnos aptos para ello.

- Elevar la calidad en el nivel de conocimiento de los alumnos.
- Garantizar la superación del 100 % de los docentes de nueva incorporación en temas relacionados con la especialidad.
- Lograr que todos los docentes activos estén vinculados a la investigación.
- Garantizar la aplicación de los resultados de las investigaciones en aras de fortalecer la formación integral de nuestros educandos.
- Garantizar la preparación del 100% de los maestros en formación, en el cumplimiento de los objetivos del año que cursan y en las especificidades de la especialidad.

De manera general se trabaja para lograr la formación integral de la personalidad de los escolares desde los primeros grados, la interiorización de conocimientos y orientaciones

valorativas que se reflejen en sus sentimientos, formas de pensar y comportamiento, acorde con el sistema de valores e ideales de la Revolución Socialista. Poseen sentimientos de amor y respeto antes las manifestaciones hacia la patria, su familia, su escuela, sus compañeros, y la naturaleza siendo estos portadores de cualidades esenciales como la responsabilidad, la laboriosidad, la honradez y la solidaridad. Vencer los objetivos desde 1ro hasta 6to grados, es la meta que se desea coincidiendo además, con los objetivos terminales para este nivel de educación.

Se propone la formación básica integral que un escolar cubano debe mostrar, sobre la base de una cultura general permitiéndole estar plenamente identificado con su nacionalidad y patriotismo. Estar consciente de la opción del socialismo, que garantice la defensa de las conquistas de la obra de la Revolución, en sus formas de sentir, de pensar y de actuar. Se trabaja para potenciar en los alumnos valores, con énfasis en la responsabilidad, la honestidad, la honradez y el patriotismo, dentro del sistema de valores a los que se aspira.

3-Diagnóstico de la situación actual del lenguaje de los escolares con disartria de la Escuela Especial Amistad Cuba Vietnam

Para el desarrollo de la investigación fue seleccionada la Escuela Especial Amistad Cuba Vietnam del municipio Santiago de Cuba. Se tomó como población 16 Especialistas de primer ciclo.

Se toma como muestra a las dos maestras de terapia ocupacional de la Escuela, y a las dos logopedas de las cuales, una es licenciada Formada en Salud Pública quien labora en la sala de rehabilitación del centro impartiendo esta disciplina y la otra es master formada en la Escuela Pedagógica Frank País García, una cuenta con 9 y 5 años de experiencias y la otra con más de treinta es jubilada reincorporada. Las dos logopedas graduadas en La Universidad de oriente con una experiencia laboral de tres y cuatro años de trabajo. De manera intencional se escogió a las cuatro especialistas, para un 100%, se tuvo como criterio de selección que las cuatro trabajan con los niños disártricos del primer ciclo de la escuela.

Para llevar a cabo un diagnóstico preciso de la muestra escogida, teniendo en cuenta la necesidad de conocer la condición del lenguaje expresivo en los escolares, y que actividades se realizan para el desarrollo de la misma durante los turnos de terapia

ocupacional se utilizaron diferentes métodos de investigación evidenciándose los siguientes resultados.

Se realizó un diagnóstico con el objetivo de valorar el estado actual que poseen la escolar diagnosticados con disartrias a través de la exploración logopédica, se constató de manera general que los escolares presentan severas dificultades en su expresión verbal lo que se manifiesta en el pobre desarrollo de la misma con un vocabulario precario limitado solo al uso de palabras cotidianas además presentan limitación en la articulación de algunos fonemas como /p/, /t/, /d/, /s/, /l/,/r/ como consecuencia de la insuficiente inervación de sus órganos y músculos articulatorios entre otros, los que incurren en errores frecuentes de pronunciación que no logran percatarse ni rectificar en el habla, 3 de ellos no responde en frases completas, lo que tiene que ver con las dificultades en la respiración pues el aire inspirado les resulta insuficiente para la fonación, 2 de ellos no son capaces de contar historias vivenciadas por sí mismos, todos logran nombrar objetos sencillos pero 6 de ellos no logran expresar su significado y utilidad, no logran decir las semejanzas y diferencias entre un objeto y otro, contestan las preguntas de manera difusa, con poca expresividad y fluidez, tienden a contestar “no sé”, dan respuestas breves con una adecuada estructuración desde el punto de vista gramatical, evitan actividades verbales lo que demuestra una carente independencia verbal, no dominan la técnica de la lectoescritura, su motricidad fina se encuentra severamente afectada, con insuficiencias en la pinza táctil y el agarre, ente otros. Con respecto a la motricidad general, aún no ha completado se validismo biológico y social 5 de ellos no saben vestirse solos, ni cepillarse, 4 logran comer sin ayuda, ninguno se acordona los zapatos por sí solo 3 presentan sialorrea con derrame y 4 solo acumulación de saliva. De los 7 tres presentan una respiración superficial y a veces tienden a hablar en la inspiración lo que le provoca que se ahoguen cuando hablan. En la voz presenta alteraciones en el tono, el timbre y la intensidad.

Indicadores que se tuvieron en cuenta para realizar el diagnóstico fueron:

1. Acciones o actividades que se desarrollan para el desarrollo de la expresión oral durante los turnos de terapia ocupacional

2-Calidad de la comunicación atendiendo a expresividad oral

a) Logicidad y claridad en las ideas que expresa

b) Estructura gramatical de lo expresado
c) Estructuración de la tarea y secuencia
d) Proyección verbal de los componentes de la tarea

3- Desarrollo de vocabulario activo y pasivo

a) -Evocación y nominación de objetos
b) -Identificación objetos y artículos empleados durante la actividad
c) -Reconocimiento de la utilidad y uso de estos objetos

4- Independencia verbal

a) -Comprensión y ejecución de la orden
b) -Ejecución y planificación de la actividad de forma oral
c) -Espontaneidad oral

5- Desarrollo de la motricidad articulatoria

a) Movimiento activo de los órganos articulatorios
b) Fuerza y coordinación de los movimientos articulatorios
c) Funcionamiento del arco del movimiento de la musculatura oro- facial.

6-Respiración fisiológica en función del habla.

Análisis de la entrevista a la especialista de terapia ocupacional. (Anexo # 1 de entrada).

La entrevista realizada a las especialistas de terapia ocupacional arrojó los siguientes resultados:

El 100% de las mismas conocen el concepto de disartria, pero no las clasificaciones ni características así como sus consecuencias en el desarrollo social de estos niños.

El 100% conocen cuáles son los escolares que presentan trastornos en la comunicación, pero no su tratamiento ni las acciones que pueden realizar durante sus clases para un adecuado desarrollo de la expresión oral.

El 100% afirma que las características más comunes en estos escolares son que no poseen buen desarrollo de su validismo bilógico y que en ocasiones se muestran insatisfechos al no poder realizar las actividades correctamente, además se muestran tímidos y poco expresivos.

El 100% plantea que no es de su interés el desarrollo de la expresión verbal en estos niños pues no lo consideran tan importante en sus turnos.

La entrevista realizada recogió las siguientes regularidades:

Existe desconocimiento de cuáles son las acciones y actividades que pueden emplear para el desarrollo de la expresión verbal durante los turnos de Terapia Ocupacional.

Se evidencia insuficiente preparación de las especialistas para el desarrollo de la expresión verbal en sus alumnos.

Se aplicó una observación directa a los turnos de Terapia Ocupacional, (Anexo 2) con el objetivo de valorar como se estimula el desarrollo del lenguaje expresivo en escolares diagnosticados con disartria, se tuvo en cuenta las actividades y acciones utilizados para que los mismos logren expresarse por sí mismos y en frases completas, además de la creación de situaciones que motiven la independencia verbal y la expresión espontanea, así como la organización y planificación de las actividades desde el punto de vista oral, se observó también la interacción alumno –terapista y viceversa adecuando estos a las características de los escolares.

Durante la aplicación de esta técnica se pudo confirmar que existe:

- Insuficiente utilización, por parte de las terapistas de acciones y actividades, para el desarrollo de la expresividad verbal en escolares con disartria
- Insuficiente atención a los escolares para el desarrollo de la expresividad verbal.

Análisis de documentos de las Especialistas:

Se realiza la revisión de clases planificadas de Terapia Ocupacional y de tratamientos logopédicos

Las especialistas tienen conocimiento de cuáles son los escolares con dificultades en la comunicación y expresión oral pero no incorpora acciones en las clases planificadas para motivarlos y ayudarlos a desarrollar su comunicación como parte del cumplimiento de las orientaciones logopédicas.

Las especialistas no incorporan en sus clases suficientes actividades donde pueda atender las diferencias individuales de estos escolares con respecto a la expresión oral.

Las clases planificadas no responden a las necesidades de los escolares con poco desarrollo del lenguaje y la comunicación.

Conclusiones generales del diagnóstico inicial:

Al analizar estos resultados se observa que predomina de forma significativa las siguientes insuficiencias:

La relación existente entre las especialistas de Terapia ocupacional y logopedia en función del desarrollo del lenguaje y la expresión oral de estos escolares como parte del método integral de atención logopédica es deficiente.

Insuficiente interés por parte de las especialistas de Terapia ocupacional por desarrollar el lenguaje y la comunicación durante sus turnos.

Insuficiente cumplimiento de acciones y actividades orientadas por la logopeda a las especialistas de terapia ocupacional durante sus turnos para el desarrollo de la comunicación y la expresividad verbal de sus escolares con Disartrias.

Presencia de escolares con insuficiente desarrollo de la comunicación y la expresividad verbal.

4-Estrategia didáctica para la rehabilitación de la disartria a partir de su implementación en la Terapia ocupacional en escolares con discapacidad físico motora de la Escuela Especial Amistad Cuba Vietnam

A continuación, se presentan los fundamentos teóricos, las exigencias básicas, la estructura y las etapas de la estrategia didáctica para la rehabilitación de la disartria en escolares con discapacidad físico motoras, además de la pretensión de evaluar su efectividad a través de los resultados obtenidos mediante los métodos y técnicas empleadas.

El significado original del término estrategia se ubica en el contexto militar. Entre los griegos, la estrategia era la actividad del estratega, es decir, del general del ejército. El estratega proyectaba, ordenaba y orientaba las operaciones militares y se esperaba que lo hiciese con la habilidad suficiente como para llevar a sus tropas a cumplir sus objetivos.

La estrategia es un sistema de planificación aplicado a un conjunto articulado de acciones, permite conseguir un objetivo, sirve para obtener determinados resultados. De manera que no se puede hablar de que se usan estrategias cuando no hay una meta hacia donde se orienten las acciones. A diferencia del método, la estrategia es flexible y puede tomar forma con base en las metas a donde se quiere llegar.

La palabra estrategia es retomada con gran frecuencia en el campo de la pedagogía y es utilizada con disímiles términos (política, táctica, técnica, práctica, procedimiento etc.) para referirse a las estrategias, lo que trae como consecuencia algunos problemas de interpretación.

En investigaciones realizadas por Valle Lima (2007) se plantea que “la estrategia es un conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas que partiendo de un estado inicial (dado por el diagnóstico) permiten dirigir el paso a un estado ideal consecuencia de la planeación.

Los componentes del sistema son:

La misión

Los objetivos

Las acciones, los métodos y procedimientos, los recursos, los responsables de las acciones y el tiempo en que deben ser realizadas.

Las formas de implementación.

Las formas de evaluación.” (Valle Lima, 2010)

Según el (MINED, 1993), La estrategia: “Es el conjunto de acciones que permiten alcanzar un objetivo, concentrando las fortalezas y las oportunidades contra las debilidades y las amenazas, tanto de la escuela como de su entorno.”(Mancebo Calzado, 2010, p. 95)

Valle Lima (2007) plantea que la estrategia didáctica: “Es el conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas que parten de un estado inicial y permiten dirigir la formación del hombre hacia determinados objetivos en un plano social general.”(p. 40).

Desde el punto de vista didáctico: se concibe en la estrategia que la enseñanza necesita de una dirección y planificación coherente del docente, de la preparación que el disponga para dirigir con éxito el proceso que dirige.

El uso de estrategias didácticas activas permite al maestro poner en práctica un nuevo rol: el de facilitar el aprendizaje, hacer que el escolar profundice en los conocimientos y descubra la relevancia que éstos tienen.

Como exigencia didáctica, la estrategia debe estar en función de las capacidades, intereses, actitudes y respuesta del grupo. Además, es preciso diversificar los tiempos y los modelos de evaluación. Las actividades de evaluación planificadas deben respetar los diferentes estilos de aprendizaje y las necesidades educativas de los alumnos, es conveniente adaptar los instrumentos de evaluación y utilizar sistemas menos académicos y complementarios como entrevistas, pruebas orales, parrillas de

observación, etc. Por último, habrá que diferenciar el sistema de tutorías para realizar una atención individualizada.

Cuando hablamos de didáctica es importante recalcar que esta es la rama fundamental de la Pedagogía ya que tiene como parte de los requisitos que le confieren su carácter de ciencia, “un objeto de estudio bien delimitado que es el Proceso de Enseñanza Aprendizaje” (Labarrere & Valdivia, 1989, p. 22).

En la presente investigación se asume la definición de estrategia didáctica que formulan de Armas Ramírez y Valle Lima (2011) quienes expresan que:

> es la proyección de un sistema de acciones a corto, mediano y largo plazos que permite la transformación del proceso de enseñanza aprendizaje en una asignatura, nivel, o institución tomando como base los componentes del mismo y que permite el logro de los objetivos propuestos en un tiempo concreto (p. 66).

Esta definición en correspondencia con la estrategia diseñada que tiene en cuenta los componentes didácticos del proceso de atención logopédica.

Después del análisis de las definiciones antes expuestas por los diferentes investigadores del tema se señalan elementos distintivos de la estrategia didáctica:

Conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje. Es sustancial, plantear estrategias didácticas que contemplen los objetivos de enseñanza-aprendizaje a partir de los diversos métodos, los cuáles deben dirigirse a las necesidades particulares de cada asignatura, por lo tanto los docentes deben conocer y emplear una variedad de actividades que le permitan concretar dichos procesos apoyados de los diversos recursos web que ofrece la educación a distancia.

Es fundamental en este momento especificar que existen seis componentes importantes que conforman el acto didáctico:(componentes de la didáctica).

1. El docente o profesor: es la persona que promueve y oriente el aprendizaje.
2. El discente o estudiante: es la persona que aprende.
3. Objetivos de aprendizaje: son las metas educativas que reflejan los logros de aprendizaje que se esperan en los estudiantes.
4. Materia: son los contenidos que son enseñados y aprendidos. Formalmente están plasmados en el currículo.

5. Los métodos de enseñanza: procedimientos seguidos para promover el aprendizaje.
6. El contexto del aprendizaje: Escenario donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, incluye el entorno social, cultural y geográfico.

También se hace referencia a los tres momentos didácticos los cuales son:

El planeamiento: es el momento en el que se prevén todos los elementos necesarios para implementar un programa educativo. Entre esos elementos se mencionan los objetivos, contenidos, estrategias, recursos didácticos, tiempos, entre otros.

La implementación: es la parte del proceso en la que se pone en marcha el programa educativo, es decir, se imparte con los alumnos. Aquí se implementa la planificación realizada, pero haciendo los ajustes pertinentes para orientar el aprendizaje de acuerdo con las necesidades de los alumnos y demás condiciones que resultaron distintas a lo previsto.

La evaluación: es un momento didáctico en el que se valora el alcance de los objetivos de aprendizaje, aunque tiene una relevancia determinante al final del proceso.

Es indispensable que se efectué de manera simultánea a la implementación, con la finalidad de responder a las necesidades de aprendizaje de los alumnos a lo largo del proceso.

Los fundamentos teóricos de la estrategia se encuentran en:

- La filosofía dialéctico materialista, la que propicia el tratamiento acerca de la educabilidad del hombre, la educación como categoría general y el por qué y el para qué se educa al hombre; teniendo en cuenta que el hombre es una realidad viva, biopsicosocial e histórica, el hombre varía en el curso de la historia, se desarrolla, se transforma, es el producto de esta.

  Se fundamenta en la teoría marxista-leninista del conocimiento, lo que permitió trazar pautas a seguir, desde la concepción del mundo que se asume, la objetividad, el papel práctico de la superación, para lograr la rehabilitación logopédica de la disartria, hasta el análisis histórico concreto del fenómeno que se estudia, tanto en el plano teórico como en el práctico.

  El enfoque dialéctico materialista subyace como base metodológica de los fundamentos teóricos sustentados en leyes y principios que rigen el desarrollo tanto en la naturaleza social y el pensamiento, el conocimiento de las leyes permite

reflejar el mundo y su unidad e integridad. Los hombres apoyándose en el conocimiento de las leyes la naturaleza y sociedad transforman la realidad objetiva en aras de satisfacer sus necesidades vitales.

- El Enfoque histórico-cultural de Vigotsky, L. S., en relación con la adquisición de los procesos psicológicos superiores en la actividad y en el marco de un contexto social determinado, sienta pautas en la preparación de los logopedas y terapistas ocupacionales en el desarrollo general de los escolares con disartria, de ello se deduce que puede concebirse como un proceso profundamente social.

  La concepción de actividad constituye un aspecto medular en la teoría histórico-cultural, desarrollada, por A. N. Leontiev (1978), es en la actividad donde se forman y desarrollan los procesos psíquicos y las cualidades de la personalidad. Según A.N Leontiev, la actividad está conformada por dos componentes: los intencionales y los procesales. Dentro de los componentes intencionales se encuentran los motivos y objetivos de la actividad y dentro de los componentes procesales las acciones y las operaciones.

  La acción constituye el proceso subordinado a una meta u objetivo conscientemente planteado. La actividad existe y se manifiesta a través de las acciones que la componen, y en la medida que se ejecuten las acciones se realiza la actividad dada. Cada acción está conformada por un sistema de operaciones que vienen a constituir pasos o peldaños a través de cuya realización transcurre la acción. La estrategia didáctica para rehabilitar la disartria, es un proceso que se desarrolla a través de actividades. En cada una de ellas están presentes los componentes descritos por A.N Leontiev, por consiguiente incluyen el objetivo, el motivo, el objeto, las acciones, las operaciones y las condiciones.

- Los fundamentos pedagógicas de esta estrategia didáctica, se proyectan desde el ideal histórico de la teoría educativa cubana y latinoamericana, sin descuidar los postulados de la pedagogía universal vigentes, aún, desde la época de Comenius, Pestalozzi, Rousseau, que colocan en el centro de su atención al ser humano (educando, educador y otros adultos influyentes) y propenden al mejoramiento humano del alumno y su preparación para la vida. Donde se plantea que la escuela

es una institución social que está relacionada con la sociedad que la da origen y a la cual sirve, esta relación tiene carácter de ley.

- Desde el punto de vista sociológico, se manifiesta en que la educación resulta condicionada por la sociedad y esta a su vez, es condicionante de su proyección futura. Siendo una realidad en nuestra sociedad, la inclusión de escolares con discapacidad físico motora (condición que impone la sociedad a la educación), es de vital importancia la superación de los especialistas de la educación especial en esta temática, para brindar la adecuada atención a estos escolares.

La estrategia didáctica conformada tiene como **objetivo general:**

Rehabilitar la disartria a partir de la elaboración de una estrategia didáctica que se aplicara en los turnos de terapia ocupacional.

Objetivos específicos:

Elevar la calidad de la atención a los escolares con disartria de la Escuela Especial Amistad Cuba Vietnam.

Contribuir a la adquisición del autovalidismo y la independencia verbal de escolares con discapacidad físico motora que tienen disartria.

Características de la propuesta:

Aplicabilidad: Es factible de ser aplicada y es de fácil manejo por parte de los Especialistas involucrados, además se ajusta a las condiciones del centro y pueden implementar en la práctica toda la teoría aprendida.

Capacidad evaluativa: Los modos de actuación se integran a cada acción y son evaluados en el proceso.

Carácter contextualizado: Las acciones tienen la posibilidad de adecuarse a las necesidades de los docentes según sus potencialidades y de manejar la bibliografía actualizada.

Flexibilidad: Permite ir adecuando las acciones a las nuevas situaciones según el objetivo trazado, esto lo permite la posibilidad que tiene de irse rediseñando.

Nivel de actualización: La estrategia materializa las actuales concepciones pedagógicas y especialmente didácticas que se demandan a nivel nacional sobre las transformaciones en la nueva universidad.

Objetividad: Las etapas de la estrategia se conciben a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de las diferentes técnicas aplicadas a los maestros en su desempeño, teniendo en cuenta sus necesidades de superación.

Estructura de la estrategia.

El proceso de enseñanza-aprendizaje para la rehabilitación de la disartria necesita ser diseñado de manera tal que los alumnos obtengan éxito en cada una de las acciones trazadas, logren un mejor desarrollo del lenguaje y la expresión oral.

Los pasos de esta estrategia constituyen puntos de referencia obligados para definir la organización que debe tener una estrategia en los marcos de un trabajo científico.

Etapas de la estrategia:

I. Diagnóstico.

II. Planificación.

III. Ejecución.

IV. Evaluación.

Duración de la estrategia:

La estrategia didáctica tendrá una duración de 6 meses; los cuales se distribuirán por las diferentes etapas:

Ira Etapa Diagnóstico.	1mes.
2da Etapa Planificación.	15 días.
3ra Etapa Ejecución.	4 meses.
4ta Etapa Evaluación.	15 días.

Primera etapa: Diagnóstico.

Objetivo: Diagnosticar el estado real del objeto.

Acción 1: Diagnóstico del desarrollo del lenguaje y la expresión oral en los escolares de la muestra.

Objetivo específico: Determinar el estado del desarrollo del lenguaje y la expresión oral en escolares disártricos de la Escuela Especial Amistad Cuba Vietnam.

Método: Prueba pedagógica, revisión de documentos, entrevista.

Fecha: 1- 31 de noviembre.

Dirige: Investigador.

Participan: Directivos del centro, docentes, familia e investigador.

Operaciones:

Revisión de los documentos relacionados de los escolares: expediente acumulativo, expedientes Psicopedagógicos, expediente logopédico (si tiene), resultados del diagnóstico de preescolar, historia clínica.

Entrevista con familiares, donde se precisará si existe algún antecedente de trastornos del lenguaje, características de su desarrollo, si recibió atención logopédica.

Entrevista con especialistas de terapia ocupacional y logopeda para determinarla apreciación de carencias en el lenguaje que han detectado durante sus turnos.

Acción 2: Diagnóstico del estado en que se encuentra la Rehabilitación de la disartria en escolares de la Escuela Especial Amistad Cuba Vietnam

Objetivo: Determinar las acciones que se realizan para rehabilitar la disartria.

Método: análisis de documentos, entrevista, observación a clases y tratamientos especializados.

Fecha: 15- 30 de noviembre.

Dirige: Investigador.

Participan: Directivos del centro, especialista e investigador.

Acción: Analizar las acciones que se realizan para la rehabilitación de la disartria no solo en los tratamientos logopédicos si no también en otros turnos que así lo posibiliten.

Operaciones:

Análisis de la estrategia didáctica para la rehabilitación de la disartria (en el centro).

Realizar un análisis de los documentos vigentes como los planes de clases, Orientaciones Logopédicas y otros documentos del (logopeda).

Entrevistas con los especialistas de Terapia Ocupacional para conocer las acciones que realizan para la rehabilitación de la disartria

Observación a clases de terapia ocupacional, para determinar las acciones que se realizan para la rehabilitación de la disartria

Segunda etapa: Planificación de la estrategia didáctica para la rehabilitación de la disartria

Objetivo: Planificar la estrategia didáctica para la rehabilitación de la disartria, determinado las metas u objetivos a corto y mediano plazo que permiten la transformación del objeto desde su estado real hasta el estado deseado.

Métodos: Análisis y síntesis, modelación, análisis bibliográficos.

Fecha: 1 – 15 de.

Dirige: Investigador.

Participan: Investigador.

Acción1: Planificación por etapas de las acciones, recursos, medios y métodos que corresponden a estos objetivos.

Objetivo: Determinar las acciones a desarrollar para la rehabilitación de la disartria

Método: Análisis y síntesis, modelación, análisis bibliográficos.

Fecha: 1 – 15 de diciembre.

Dirige: Investigador.

Participan: Directivos del centro, docentes e investigador.

Operaciones:

1. Diseñar las acciones a desarrollar en la estrategia.

Determinar las acciones para el desarrollo de los escolares teniendo en cuenta sus necesidades comunicativas en el lenguaje.

Determinar los espacios donde se desarrollarán estas acciones (Escuela Especial para niños con Limitaciones Físico motoras).

Determinar cuáles serán los agentes educativos que desarrollarán estas acciones.

Identificar el contenido a desarrollar por cada agente y su objetivo.

Organizar las actividades a desarrollar por cada uno de los participantes atendiendo a las funciones que le sean asignadas.

Determinar la duración: Diseñar qué tipo de evaluación se empleará, en qué momento, quiénes participarán y la forma que adoptarán.

Precisar informaciones que pueden ser utilizados en la estrategia didáctica, teniendo en cuenta el nivel profesional y de especialización en la tarea que se requiere, experiencia profesional y líneas de investigación que desarrolla la persona en cuestión.

Acciones para la rehabilitación de la disartria a través de los turnos de Terapia Ocupacional.

Actividades básicas de la vida diaria.

Actividad 1. El niño y su cuerpo.

Objetivo**:** conversar acerca de las partes que forman el cuerpo humano, observarlas, reconocerlas, nombrarlas y describirlas.

Es importante tener en cuenta que se respeten las posibilidades funcionales (se le ordenará tocar con la mano contraria al hemisferio que se va a explorar) del escolar.

Método**:** Demostrativo explicativo

Procedimientos**:** Conversación, observación, preguntas y respuestas, explicación, descripción, masajes terapéuticos, psicoterapia

Medios de enseñanza**:** espejo, rompecabezas, maquetas, textos breves, software educativos relacionados con la temática, canciones, entre otros.

Reconocimiento de todas las partes que forman la cabeza.

Se comenzará el reconocimiento señalando las partes de la cabeza: frente, ojo, oreja, pómulos, boca y nariz, palmeándose a la orden del especialista, lo que estimulará a su vez las partes señaladas.

Recomendaciones logopédicas:

El maestro logopeda con esta actividad propiciará el desarrollo del vocabulario activo pidiéndole al escolar que nombre a su vez las partes del cuerpo mientras las palpa e identifica debe expresar además para que la utilizamos a través de un lenguaje oracional sencillo y coherente. Esta actividad potenciara además la activación de la musculatura oro facial pues cuando llegue a la boca el logopeda aprovechara para realizar ejercicios masticatorios, juegos linguales y otros que le permitan la de los órganos fonoarticulatorios. Permitirá también el aprendizaje de los fonemas (d; p; b) cuando corresponda, además a través del propio ejercicio se integra con el objetivo de activar los procesos del pensamiento, en este caso que logre generalizar.

Actividad·2 ¿Qué parte del cuerpo Me toco ahora?

Objetivo: ampliar los conocimientos que los escolares poseen acerca de las partes que forman el cuerpo humano, observarlas, reconocerlas, nombrarlas y describirlas.

Método**:** Demostrativo explicativo

Procedimientos**:** Conversación, observación, preguntas y respuestas, explicación, descripción, masajes terapéuticos, psicoterapia

Medios de enseñanza**:** espejo, rompecabezas, maquetas, textos breves, softwares educativos relacionados con la temática, canciones, entre otros.

Reconocimiento de todas las partes que forman la cabeza.

¿Para que utilizamos la boca?

¿Demuéstrame los movimientos que hace tu boca cuando come?

¿Además de comer que otra cosa hacemos con la boca?

Te invito a realizar un ejercicio con la boca que te va a encantar. Pronunciación del fonema /P/

¿Qué parte de la boca usamos en este ejercicio?

Reconocimiento y descripción de las partes que conforman el tronco y las extremidades.

Actividad: 3 Reconociendo el cuerpo humano.

Objetivo: conversar acerca de las partes que forman el cuerpo humano, observarlas, reconocerlas, nombrarlas y describirlas.

Método**:** Demostrativo explicativo

Procedimientos: Conversación, observación, preguntas y respuestas, explicación, descripción, masajes terapéuticos, psicoterapia

Medios de enseñanza: espejo, rompecabezas, maquetas, textos breves, softwares educativos relacionados con la temática, canciones, Imágenes, entre otros.

Al igual que en el ejemplo anterior, los escolares señalarán, y describirán a la orden del especialista, las partes involucradas: piernas, brazos, manos, hombros y rodillas además de expresar para que se utilizan en esta actividad podremos utilizar los rompecabezas especializados que muestran todas las partes del cuerpo humano.

(Imágenes). El logopeda señalará la parte del cuerpo y el alumno dirá que es y cómo la utilizamos.

Actividad 4: Conociendo más mi cuerpo a través de los objetos.

Objetivo: conversar sobre objetos y fenómenos de la vida diaria a partir de actividades prácticas sencillas, que permitan comprender las funciones de los órganos de los sentidos y la orientación espacial.

Método**:** Demostrativo explicativo

Procedimientos**:** Conversación, observación, preguntas y respuestas, explicación, descripción, masajes terapéuticos, psicoterapia

Los escolares comprenderán la necesidad de cosas que forman parte del mundo que les rodea, objetos, posiciones y direcciones. Los alumnos deben conocer y emplear las relaciones de posición en el espacio partiendo de su cuerpo.

Se familiarizarán e identificarán el espacio que comparten en la escuela. Desarrollarán habilidades de observación sistemática de los objetos, y del conocimiento del medio.

Esta temática permitirá el desarrollo del vocabulario activo de los escolares, así como el desarrollo del componente gramatical del mismo ordenando oraciones en las que nombrará objetos y ubicará el lugar donde se encuentran con respecto a su esquema corporal.

En el tratamiento de las relaciones espaciales tienen gran importancia las posiciones derecha-izquierda, delante-detrás, arriba-abajo. Es fundamental que el escolar sirva de muestra para realizar esta actividad, demostrando con sus brazos y piernas las diferentes posiciones, estos ejercicios de orientación en el espacio ayudará a nuestros estudiantes a ubicarse en la hoja de papel, reconocer y diferenciar letras, entre otras actividades.

Nómbrame los objetos que tiene a tu derecha o a tu izquierda

¿Para qué se utilizan estos objetos?

Descríbelos por su forma, color y tamaño.

Actividad ·5 Orientación de los planos delante y detrás.

Objetivo**:** Describir objetos reales que los rodean, favoreciendo el desarrollo del vocabulario y la orientación espacial

Método**:** Demostrativo explicativo

Procedimientos**:** Conversación, observación, preguntas y respuestas, explicación, descripción, masajes terapéuticos, psicoterapia

Medios de Enseñanza: láminas objetos reales, computadora

Se podrá comenzar la actividad pidiendo a los alumnos que describan todo lo que pueden ver frente a ellos, para esto, se pueden utilizar láminas objetos reales, se podrá motivar a través de un video o trabajar en la computadora con software educativos. Todas estas actividades, servirán de fundamento para explicar que todo lo que han observado frente a ellos es el plano “delante”. Durante esta actividad, los alumnos deben señalar con los miembros superiores, lo que observan, así ejercitaremos los diferentes arcos articulares.

Terminado este ejercicio, se les explicará que todo lo que tienen a sus espaldas, o sea, opuesto a lo que están observando delante, es el plano “detrás”. Para lograr este objetivo se puede colocar al niño en diferentes lugares del local. Donde se le puedan realizar preguntas relacionadas con la ubicación de diferentes áreas. Para finalizar esta actividad, se puede cambiar la posición de los escolares, de espaldas a lo que era el frente, y explicarles, que lo que antes era “delante”, ahora es “detrás”.

Actividad 6 Orientación de los planos derecha e izquierda.

Objetivo: Describir objetos reales que los rodean, favoreciendo el desarrollo del vocabulario y la orientación espacial

Método**:** Demostrativo explicativo

Procedimientos**:** Conversación, observación, preguntas y respuestas, explicación, descripción, masajes terapéuticos, psicoterapia

Medios de Enseñanza**:** láminas objetos reales, computadora

Es necesario explicar que el alumno primero debe dominar los planos derecha e izquierda partiendo de su propio cuerpo para posteriormente orientarlo con relación al medio que lo rodea.

En el puesto de trabajo, colocar objetos hacia la derecha e izquierda que deberán identificar y seleccionar, nombrar y describir según forma, tamaño y color. Mediante estas actividades se potenciarán otras habilidades que se corresponden con el desarrollo psicomotor afectado o no (extensiones, flexiones y agarres favorecedores de los diferentes planos articulares).

Actividad: 6 Conozcamos las prendas de vestir.

Objetivo desarrollar habilidades de observación, descripción y comparación de las prendas de vestir y las partes que la componen.

Método**:** Demostrativo explicativo

Procedimientos**:** Conversación, observación, preguntas y respuestas.

Medios de Enseñanza**:** prendas de vestir, laminas, tarjetas.

Es importante tener certeza que el escolar conozca cada una de las prendas de vestir Además, les permite identificar el derecho y el revés de las prendas de vestir para así tener una mejor estética al vestirse. Se considera importante el trabajo desarrollado en

esta unidad, ya que permite a los escolares identificar la forma correcta de usar las prendas de vestir (derecho y revés).

Actividad: 7 conociendo todas las partes que componen mi ropa**.**

Objetivo desarrollar habilidades de observación, descripción y comparación de las prendas de vestir y las partes que la componen.

Método**:** Demostrativo explicativo.

Procedimientos**:** Conversación, observación, preguntas y respuestas, explicación.

Medios de Enseñanza: prendas de vestir, laminas, tarjetas.

Mediante la utilización de diferentes prendas de vestir: camisas, pantalones, blusas, sayas y otras, el especialista les irá mostrando las diferentes partes: mangas, ojales, botones, cuello, bolsillo, faja, bajo, portañuela, entre otras, que los relaciona con las prendas mostradas, sirven de material de apoyo los medios audio visuales con cuentos y dibujos animados, láminas, para describir el vestuario.

El logopeda le mostrara al niño las diferentes prendas de vestir y le pedirá que las nombre y las describa, además debe explicar su uso.

Escogerá una prenda intencional mente en donde aparezca el sonido que desea trabajar y aprovechará para su automatización

El Logopeda orientará al niño a que nombre las partes de la prenda utilizada y explique donde va o para que sirva ejemplo los botones sirven para cerrar la camisa o el pantalón.

Actividad: 8 ¿Cómo vestirnos?

Objetivo desarrollar habilidades de observación, descripción y comparación de las prendas de vestir y las partes que la componen.

Método**:** Demostrativo explicativo

Procedimientos**:** Conversación, observación, preguntas y respuestas, explicación, descripción, masajes terapéuticos, psicoterapia

Medios de Enseñanza: prendas de vestir, laminas, tarjetas.

En esta temática se trabaja para que los escolares despierten el interés por desarrollar habilidades que le permitan valerse por sí solos. Además, mejora sus condiciones físicas para lograr la independencia necesaria en las actividades de la vida diaria al desarrollar la amplitud en los movimientos y la coordinación de actos motores. En esta actividad el logopeda pedirá al niño que explique de forma verbal como se viste.

Se considera importante el trabajo de esta unidad por facilitar en los escolares el descubrimiento de sus potencialidades para el desempeño en las actividades de la vida diaria que elevan la calidad de vida e influyen en los niveles de autoestima.

Para el logro de esta actividad se precisa de ropas cómodas despegadas del cuerpo en correspondencia con la patología de los escolares, para que les sea más fácil alcanzar los objetivos propuestos. Desvestir miembros superiores: Camisa

El especialista hace una demostración de cómo quitarse la camisa y de manera conjunta explica cómo hacerlo: inclinando el tronco hacia delante, llevar la mano a la espalda tomando la prenda de vestir, tratando de subirla arrugando la ropa hasta llevarla al cuello por la cabeza, y terminar deshaciéndose de esta. Con esta técnica, se podrán desvestir con camisa.

El logopeda pedirá a los escolares que describan de forma verbal la actividad que van a realizar, además les presentara las prendas que se van a utilizar y les pedirá que nominen, nombren y describan (por su color textura tamaño) las prendas utilizadas en la actividad.

Luego de finalizar la actividad el logopeda pedirá al niño que describa como lo hizo.

Actividad 9 -Aprendamos a comer.

Objetivo de esta temática es desarrollar el lenguaje de los escolares con disartria a partir del aprovechamiento de la satisfacción de las necesidades primordiales de independencia en la alimentación que favorecen una mejor calidad de vida e integración social.

Método**:** Demostrativo explicativo

Procedimientos**:** Conversación, observación, preguntas y respuestas, explicación, descripción, masajes terapéuticos, psicoterapia

Medios de Enseñanza: platos, cucharas, tenedores, vasos, servilletas…

Con esta actividad se Propicia al escolar confianza y seguridad en el desarrollo de habilidades en el proceso de alimentación a partir de sus particularidades y potencialidades en el área motriz, así como formas, normas de comportamiento, hábitos higiénicos y de conducta para la alimentación.

En esta unidad pretendemos enseñar a los escolares una correcta formación a la hora de comer, como comportarse en la mesa, la forma debida de ingerir los alimentos,

instaurar o corregir la masticación, cómo utilizar los cubiertos, entre otros. El papel del logopeda en esta temática consiste en Describir todos los utensilios que se emplearan en esta actividad Platos, cucharas etc. Además de expresar su utilidad e importancia. Los niños expresaran que actividad van a realizar y como lo harán empleando el orden lógico de la actividad.

Se aprovecharán los alimentos pues los escolares podrán expresar mediante esta actividad lo que van a comer y qué importancia tiene el consumo de estos alimentos para su crecimiento.

Atendiendo a las particularidades de los escolares, se corrigen los hábitos incorrectos al tomar los líquidos, tratando de eliminar los patrones inadecuados que han adoptado por comodidad, como el de succión. Para lograr esto es indispensable la participación del logopeda en la orientación de los métodos adecuados para la formación de las habilidades que permitan compensar

Estas deficiencias.

Para inhibir la protrusión lingual se debe evitar el uso del biberón, se ejercerá presión con el dedo índice bajo la boca, se darán masajes en los músculos de la de la mandíbula en un movimiento anteroposterior. Para el babeo se debe enseñar a tragar, educándolos a masticar realizando los movimientos propios de la masticación.

Se ayuda al escolar a corregir la masticación grosera, siguiendo los métodos utilizados por el logopeda a través de ejercicios que facilite el trabajo de los músculos que intervienen en la masticación, por ejemplo:

-Masajear los músculos de la base de la mandíbula, en movimiento antero posterior en dirección al cuello, ejerciendo presión firme.

-Inflar mejillas

-Realizar con la lengua movimientos en cuatro direcciones, arriba, abajo, izquierda derecha.

-Soplar, besos, labios explosivos, etc.

El logopeda: brindara una explicación acerca de la importancia de los hábitos comensales.

Se le dará cumplimiento a este objetivo a través de la mesa modelo, actividad en la que todos los escolares participan para adquirir hábitos comensales. De esta forma resumen

todas las actividades que se han ido corrigiendo y/o compensando sistemáticamente, enfatizando en la postura, masticación adecuada, el modo de utilizar todos los cubiertos, y de compartir la mesa en familia u otros comensales.

Las actividades a realizar por parte de los educandos estarán en función de sus posibilidades reales y la creatividad del profesional.

Al final los escolares podrán emitir su criterio acerca de la temática abordada a través de un lenguaje oracional enriquecido en cuanto a calidad y cantidad.

Actividad: 10 Un niño aseado.

Objetivo: conversar sobre la importancia del mantenimiento de la higiene y cuidado personal, aspecto necesario para mantener la salud.

Método**:** Demostrativo explicativo.

Procedimientos**:** Conversación, observación, preguntas y respuestas, explicación, descripción, masajes terapéuticos, psicoterapia.

Medios de Enseñanza**:** láminas, tarjetas, computadora.

Especial atención requiere el objetivo dirigido a desarrollar hábitos de higiene individual como medida preventiva para evitar riesgos y enfermedades. Se les explica además dónde y cómo se atiende la salud en las diferentes instituciones y quienes son las personas que están preparadas para brindarnos todo tipo de atención. Es necesario educar al escolar sobre la importancia de la apariencia y la higiene general de cada persona para mantener la salud, por ello se hace todo lo posible porque nuestros escolares mantengan una apariencia correcta a pesar de sus limitaciones.

El escolar después de concluir la actividad conversara sobre la importancia de mantener una buena higiene personal, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿consideras tú importante el mantenimiento de una buena higiene personal? ¿Por Qué?, ¿Cómo cuidas tu higiene y salud?

Actividad: 11 Cuidado de los dientes y uso del cepillo.

Objetivo: conversar sobre la importancia del mantenimiento de la higiene y cuidado personal, aspecto necesario para mantener la salud.

Método**:** Demostrativo explicativo

Procedimientos**:** Conversación, observación, preguntas y respuestas, explicación.

Medios de Enseñanza: espejo, cepillo de dientes, tarjetas.

A través de una conversación se les explica a los escolares la importancia de la higiene bucal, que el cepillado se realiza cuatro veces al día, después del desayuno, almuerzo, comida y antes de acostarse, este último el más importante, pues es cuando la boca permanece mayor tiempo cerrada y los microorganismos actúan provocando caries.

Para explicarles cómo debemos cepillarnos los dientes, las encías y la lengua, se hará la demostración y el estudiante imitará según posibilidades, tratando de limpiar todas las caras de los dientes varias veces para evitar las caries. El cepillado propicia un beneficioso masaje sobre las encías activando la circulación de la sangre y estimulando la formación de tejido resistente a infecciones e inflamaciones.

El Logopeda explicará la necesidad de mantener la apariencia e higiene personal, pues es un factor importante a la hora de las relaciones interpersonales. Se insiste de igual forma en el correcto uso del uniforme escolar y sus atributos, en el cuidado de las prendas de vestir y la limpieza para mantenerlas, el uso del desodorante para evitar olores desagradables, la limpieza y cuidado del cabello, entre otras. Se ejercitarán contenidos anteriores en cuanto al doblado de la ropa y manipulación del peine.

Se pueden apoyar en láminas u otros medios para que el alumno realice valoraciones, describan, converse sobre la Imagen adecuada o inadecuada.

Tercera etapa: Ejecución de la estrategia didáctica.

Objetivo: Implementar las acciones a desarrollar para la rehabilitación de la disartria en los turnos de terapia ocupacional.

Métodos: Conversación heurística, explicación, observación y análisis documental.

Fecha: 4 meses.

Dirige: Investigador.

Participan: docentes e investigador.

-Acción 1. Orientar las acciones trazadas para la rehabilitación de la disartria

Métodos: Conversación heurística, explicación, observación y análisis documental.

Fecha: 4 meses.

Dirige: Investigador.

Participan: Especialistas e investigador.

Operaciones:

1. Orientar las actividades a desarrollar durante la implementación de la estrategia, los resultados esperados, así como el uso de los medios de enseñanza con el propósito de despertar el interés y mantener la motivación por el contenido a trabajar.

2. Estimular, desde la propuesta de actividades, la motivación e interés de los especialistas por el aprendizaje utilizando los medios de enseñanza, la actualización de los contenidos y las formas de organización que serán utilizadas.

- Acción 2: Ejecución de la estrategia por parte de los Especialistas.

Métodos: observación y análisis documental.

Fecha: 4 meses.

Dirige: Investigador.

Participan: Especialistas e investigador.

Operaciones:

1. Ejecución de las acciones por parte de los Especialistas.

Estas acciones se instrumentarán en los sistemas de tratamientos.

Dar seguimiento a la solución de tareas por parte de los Especialistas mediante la observación a clases, análisis de los planes de tratamientos.

Diferenciar los avances que alcanza en el desarrollo de su lenguaje y expresión oral

Dar seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y actividades logopédicas, por parte de los Especialistas mediante el análisis de estas en las sesiones de trabajo.

Cuarta etapa: Evaluación de la estrategia.

Objetivo: Valorar la efectividad de la estrategia.

Métodos: Análisis y síntesis, entrevista, observación.

Fecha: 15 días.

Dirige: Investigador.

Participan: Directivos del centro, docentes e investigador.

Acciones 1. Evaluación de la estrategia didáctica.

Métodos: Análisis y síntesis, entrevista, observación, prueba pedagógica.

Fecha: 15 días.

Dirige: Investigador.

Participan: Directivos del centro, docentes e investigador.

Operaciones:

Confeccionar los instrumentos a aplicar (entrevista, observación a talleres de terapia ocupacional, pruebas pedagógicas).

Aplicación de los instrumentos: entrevistas a docentes, observación a talleres de terapia ocupacional, pruebas pedagógicas.

Tabulación de los resultados de los instrumentos aplicados.

Determinar el estado en que se encuentra el lenguaje de los niños luego de aplicada la estrategia.

Definición de los logros, los obstáculos que se han ido venciendo, valoración de la aproximación lograda al estado deseado.

Uso de la escala valorativa para evaluar su calidad.

5-Evaluación de la factibilidad y pertinencia de la estrategia didáctica para la rehabilitación logopédica de la de la disartria a partir de su implementación en los talleres de terapia ocupacional en la Escuela Especial para niños con discapacidad físico motora Amistad Cuba – Vietnam

Para valorar la factibilidad de la implementación de la estrategia didáctica para la rehabilitación logopédica de la disartria, a partir de su implementación en los talleres de Terapia Ocupacional, en la Escuela especial para escolares con Discapacidad Física motoras Amistad Cuba Vietnam, se emplearon los siguientes métodos de investigación: Entrevistas a especialistas, la encuesta a especialistas, observación

La estrategia didáctica permitió enriquecer la actuación de logopedas y especialistas de terapia ocupacional ante las demandas y dificultades que tienen los escolares con discapacidad físico motora en su lenguaje y autovalidismo, lo cual permitió el desarrollo no solo de su autonomía sino también de su de su vocabulario y expresión oral a través de la ejecución de actividades de la vida diaria planificadas previamente de forma verbal empleando el orden lógico secuencial del lenguaje y la actividad.

Con el objetivo de realizar una evaluación de la estrategia didáctica para la rehabilitación logopédica de la disartria, implementada en los talleres de Terapia Ocupacional se tuvieron en cuenta indicadores que permitieron evaluar el desarrollo del lenguaje y la expresión oral:

Indicadores:

Exponer criterio acerca de la estructura de la estrategia didáctica para la rehabilitación logopédica de la disartria, implementada en los talleres de Terapia Ocupacional a través del desarrollo de actividades de la vida diaria.

Exponer criterio acerca de la importancia de la estrategia didáctica para la rehabilitación logopédica de la disartria, en la adecuada atención diferenciada de los escolares con discapacidad físico motora en correspondencia con sus dificultades.

Valorar la estrategia como instrumento para evaluar el desarrollo del lenguaje y la expresión oral afectado en estos escolares.

Ofrecer recomendaciones que permita enriquecer la estrategia Didáctica.

Resultados de la encuesta a especialistas

Se aplicó una encuesta a 16 especialistas para evaluar la efectividad de la propuesta, los cuales fueron seleccionados intencionalmente antes de realizar la aplicación de la propuesta.

Los especialistas seleccionados están conformados por 3 rehabilitadores 4 maestros, 1director, 4 logopedas, 2 metodólogos, 1 psicólogo y 1 psicopedagogo, teniéndose presente la correspondencia con los resultados alcanzados en su trayectoria de trabajo, los años de experiencia y la relación con la temática que se investiga, a los que se les aplicó encuestas y entrevistas para determinar la validez obtenida de la estrategia didáctica aplicada en la atención correctiva.

Los resultados de la encuesta a especialistas evidencian las siguientes regularidades:

En los resultados obtenidos de los especialistas encuestados con relación a la estructura de la estrategia didáctica de atención correctiva a los escolares con discapacidad físico motora que presentan disartria se pudo observar que el 66,6 % de los rehabilitadores expresa que es muy adecuada debido a que se ajusta a las necesidades de los escolares. Por su parte el 50 % de los maestros así como el 100% de los metodólogos plantean que es muy adecuada porque permite a los escolares enriquecer su vocabulario a través de actividades cotidianas de la vida diaria mediante objetos y fenómenos reales que desarrollan a la vez su autovalidismo, el 33,3 % de los rehabilitadores restantes considera que es adecuado teniendo en cuenta que se ajusta a las necesidades de los mismos, mientras que el 75% de los logopedas consideran que es muy adecuada y el 100% de

los psicopedagogos, psicólogos y director expresan que es adecuada la estructura de la misma.

Sobre la importancia que le conceden a esta estrategia, el 58,3% de los rehabilitadores plantea que es muy adecuada, porque se ajusta a las necesidades de los escolares con discapacidad físico motora que presentan también disartria. En tanto el 50% de los maestros así como el 100% de los metodólogos y Directores coinciden en plantear que es adecuada, los cuales consideran en general, que se ajusta a las necesidades de los escolares con discapacidad físico motora que presentan también dificultades en el lenguaje.

En tal sentido el 75% de los logopedas consideró que es muy adecuada la propuesta y el 100% de los psicopedagogos y psicólogos la consideró de adecuada por su importancia para la labor correctiva con dichos escolares.

Al indagar si la estrategia didáctica propuesta permite evaluar el desarrollo del lenguaje y la expresión oral que se les dificultan a los escolares, el 100% de los logopedas expresa que es muy adecuada para el desarrollo del vocabulario, la motricidad articulatoria y la respiración que se dificultan; el 16,6% de los maestros y el 100% de los metodólogos estuvieron de acuerdo al valorar que es muy adecuada. Por su parte el 66% de los rehabilitadores y el 100% de los psicopedagogos y psicólogos expresa que es adecuada la propuesta para realizar la evaluación de estos escolares.

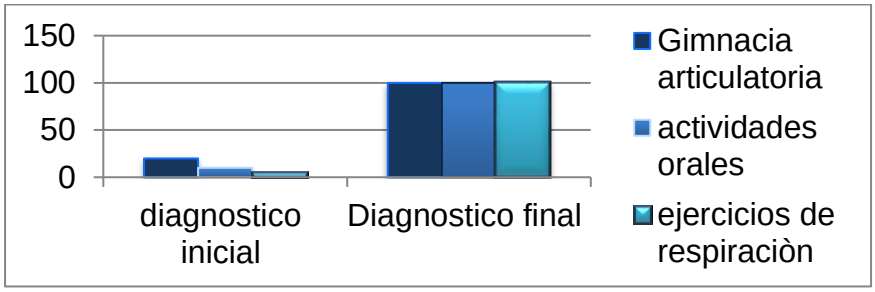
Los encuestados realizan las siguientes recomendaciones:

El 90% plantean que para enriquecer la estrategia Didáctica, se debe lograr una correcta estrecha relación entre los especialistas de terapia ocupacional y logopedia, así como del resto de especialistas que laboran con los educandos con el fin de favorecer la atención logopédica integral de los educandos.

El 95% plantea que se deben aprovechar los recursos y medios de enseñanza que forman parte de la vida diaria del escolar así como las actividades que se realizan en la misma, con el fin de potenciar el vocabulario activo y la expresión oral de los escolares con discapacidad físico motora que presentan disartria.

El 60% plantea que al realizar las actividades correctivas, estas deben propiciar el desarrollo de la respiración y la gimnasia articulatoria en forma de juego donde primero

se trabaje la relajación psicofísica de los escolares para que se sientan dispuestos a planificar y ejecutar la actividad física y verbal como se sugiere en la estrategia.

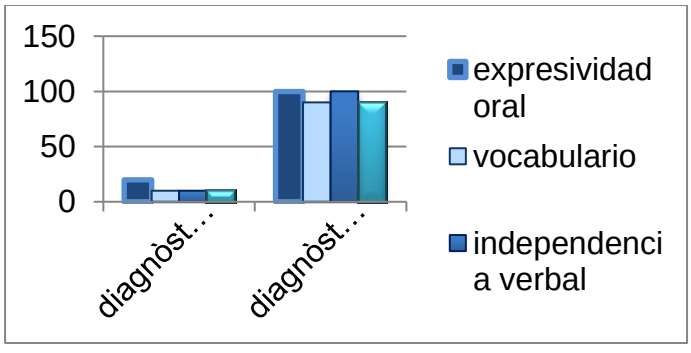


Entrevista a Logopedas

Se entrevistaron 2 logopedas de la escuela especial Amistad Cuba Vietnam. El 100% de los entrevistados plantean que la estrategia propuesta para su aplicación en escolares con discapacidad físico motora que presentan disartria posibilita la preparación para llevar acabo la atención correctiva compensatoria de estos escolares.

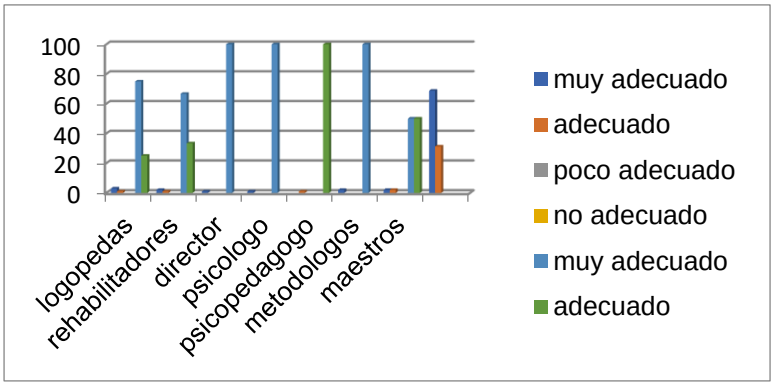
Expresan los entrevistados que el 100% de los escolares alcanzaron avances significativos en el desarrollo de su motricidad articulatoria lo que repercute de manera muy positiva en la pronunciación de palabras y sonidos, de estos el 88, 4 % (23 escolares) tuvo mejores resultados porque 3 de los escolares que representa el 11, 5%, se evalúan de regular presentaron dificultades en la respiración y sialorrea, lo que se manifiesta en falta de fluidez y expresividad.

El 100% de los logopedas entrevistados expresaron que se aplica la estrategia didáctica en los Talleres de terapia Ocupacional, empleando las actividades de la vida diaria y desarrollando en las mismas las etapas de trabajo logopédico en función de rehabilitar el lenguaje y la expresión, las cuales permiten la atención a los escolares de manera general lo cual resulta de gran importancia para su futura vida social.



Recomiendan los entrevistados que al realizar las actividades correctivas, estas deben propiciar el desarrollo del lenguaje y la expresión oral en donde primero se trabaje con la motricidad articulatoria, el masaje y la respiración tal como se plantea en la estrategia propuesta.

Resultados generales sobre el criterio de los especialistas sobre la efectividad de la propuesta.



La experiencia compartida en este trabajo pretende sembrar la motivación y la necesidad de trabajar y conocer más sobre el desarrollo de la atención logopédica aplicada en la práctica de Terapia Ocupacional. El estudio presentado tiene una perspectiva a mediano y largo plazo para poder implementar una estrategia didáctica, que se aplicará regularmente en sus contextos cotidianos a través de las actividades de la vida diaria durante las clases de terapia ocupacional. Como se ha descrito anteriormente, teóricamente el uso del lenguaje en la planificación y resolución de una tarea de la vida cotidiana es una buena herramienta de intervención, ya que genera una oportunidad real de aumentar las habilidades de las personas y disminuir las barreras que presenta el contexto físico, permitiendo la participación en actividades que de otra forma, no serían posibles. Durante la implementación de la estrategia, se devela que esta área de Terapia Ocupacional necesita de cierta calificación o especialidad, sobre todo conocimientos de propios de la disciplina además de las competencias tradicionales que exige la profesión; el determinar el perfil ocupacional del alumno y un análisis de su desempeño. Es por ello que resulta de vital importancia la fusión entre el trabajo del logopeda y el terapeuta ocupacional. Actualmente en Cuba existen algunas experiencias y sistematizaciones sobre la integración de diferentes ciencias en función de rehabilitar el lenguaje en escolares con disartria, pero aún estamos lejos en el desarrollo de esta temática en

relación a otros países, es por esta razón que es deber de nuestra profesión, empezar a generar posibles evaluaciones y guías de intervención acorde a la realidad nacional.

En Cuba se están implementando desde el año 2013 a partir del método integral descrito por la doctora Gudelia Fernández Pérez de alejo, pero aún falta mucho por desarrollar y luchar, buscando elevar la calidad de vida de los escolares con discapacidad físico motora elevando el potencial no solo físico, sino también oral y emocional. En cuanto a elementos prácticos observados, la estrategia complementa los enfoques tradicionales, que exige la atención logopédica integral que se aplica en los diversos contextos para comprender todas las aristas de la persona afectada. Se visualiza como una opción real para manejar el desempeño, pero al igual que la mirada de rehabilitación tradicional, muchas veces no se configura como la forma más rápida y eficiente para obtener resultados.

En cuanto a los resultados obtenidos, es posible señalar que la implementación de esta estrategia, ha mejorado el desarrollo del lenguaje y la expresión oral de estos escolares, permitiendo que aumente su independencia verbal y la autonomía, La habilidad de poder responder a preguntas simples, intentar aportar en una conversación y sobre todo manifestar ciertos deseos. Con esta estrategia damos la oportunidad a personas con discapacidad de poder expresar lo que sienten, lo que necesitan y desean realizar de manera planificada y organizada, además de poder participar en ocupaciones acorde a su edad, fomentar y estimular su desarrollo, y permitir ejercer sus derechos al interior de la sociedad. Pero aún hay muchos desafíos en el área y se invita a los profesionales seguir investigando y probando esta estrategia, además de compartir sus experiencias tanto dentro y fuera del ámbito profesional.

CONCLUSIONES

Las concepciones que fundamentan la rehabilitación de la disartria y la atención que en este proceso se brinda a los escolares con discapacidad físico motora en la adquisición de herramientas básicas, debido a alteraciones que limitan el lenguaje y la realización de actividades básica para la vida diaria, enfatizan en abordar el aspecto físico- motor y el aspecto de la comunicación oral , de manera que puedan alcanzar los escolares una adecuada atención especializada en la que se le de tratamiento a las diferentes áreas afectadas.

Constituye un aspecto importante de la evolución histórica de la atención logopédica a los escolares con discapacidad físico motora que presentan disartria, la necesidad de continuar perfeccionando la atención correctiva a las dificultades del lenguaje, e incluir en los programas de preparación a los diferentes profesionales que trabajan con esta especialidad la atención logopédica como parte del método integral.

Se constató a través del diagnóstico de la situación actual que los especialistas de Terapia Ocupacional que laboran con los escolares de la Escuela Especial Amistad Cuba-Vietnam para niños con discapacidad físico motora en el proceso de rehabilitación no realizan acciones para desarrollar el lenguaje y la expresión oral de estos escolares aspecto que no favorece la formación integral de los mismo, evidenciándose la necesidad de diseñar una estrategia didáctica que permita el perfeccionamiento de la atención integral a esta discapacidad.

Se constató la importancia de la estrategia propuesta para la atención integral de los escolares con discapacidad físico motora en el proceso de rehabilitación ya que mediante este, se le proporciona la cantidad suficiente de experiencias, a través de las cuales se puede lograr incrementar el control sobre su cuerpo, las dimensiones espacio corporales así como el conocimiento del medio, y la participación e interacción con el mismo a través de las actividades de la vida diaria y del lenguaje oral para el mejoramiento de su calidad de vida y su expresión oral para la inclusión en la sociedad.

RECOMENDACIONES

- Continuar generalizando la aplicación de la estrategia propuesta en otros centros de educación especial y salas de rehabilitación.
- Enriquecer la estrategia con nuevas actividades que permitan el perfeccionamiento de la atención logopédica integral a los escolares con discapacidad físico motoras.
- Presentar la investigación desarrollada en eventos y talleres científicos

BIBLIOGRAFÍA

Alvarez Lami, L. (2016). *Disartria - Resumen Clinica medica*. Retrieved 26 de julio from https://www.studocu.com/es-ar/document/universidad-nacional-del-litoral/clinica-medica/disartria-resumen-clinica-medica/2820541

Álvarez Lami, L., Fernández Collazo, L., Ferrer Sarmiento, A., López Betancourt, M., Capó Alonso, M. T., Regal Cabrera, N., Castellano Toro, G., Sardiñas Peña, Á., Pazo Quintana, T., Cabrera Díaz de Arce, I., Montesino Bejerano, E., Ochoa Barrientos, N., & Rodríguez Gómez, A. M. (2008). *Logopedia y foniatría*. Ciencias Médicas.

Álvarez Martínez, E. (2020). *Atención logopédica en escolares con retraso del lenguaje* [Tesis para optar por el Título Académico de Master, Universidad de Oriente]. Santiago de Cuba.

APA. (2013). Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5. Asociación Americana de Psiquiatría. www.psych.org

ASHA. (2022). *Los trastornos de la voz*. ASHA. Retrieved 7 de diciembre from https://www.asha.org/public/speech/spanish/los-trastornos-de-la-voz/

Azcoaga, J. (2008). Del lenguaje al pensamiento verbal. Editorial Pueblo y Educación.

Bell Rodríguez, R. (1996). *Sublime profesión de amor*. Pueblo y Educación.

Bell Rodríguez, R. (1997). *Educación Especial: Razones, visión actual y desafíos*. Editorial Pueblo y Educación.

Busto, B. M. (1998). *Manual de logopedia escolar: Niños con alteraciones del lenguaje oral en educacion infantil y primaria*. CEPE.

Bustos Sánchez, I. (1984). *Reeducación de los problemas de la voz*. Edición Revolucionaria.

Bustos Sánchez, I. (1995). *Tratamiento de los problemas de la voz*. Cepe.

Cabanas Comas, R. (1978). *Temas logofoniátricos*. Ministerio de Salud Pública, Hospital Psiquiátrico de La Habana. https://books.google.com.cu/books?id=zhpgAAAAMAAJ

Cabanas Comas, R. (1980). *Acerca de una teoría del origen del habla en la humanidad con derivaciones terapéuticas: nueva interpretación*. Hospital Psiquiátrico de La Habana.

Cáceres Zúñiga, F., Granada Azcárraga, M., & Pomés Correa, M. (2018). Inclusión y Juego en la Infancia Temprana. *Rev. latinoam. educ. inclusiva*, *12*(1), aprox. 15 p. https://doi.org/ http://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782018000100181

Castellanos Simons, B. (2009). Etapas de la investigación educativa. In R. A. Sierra Salcedo & E. Caballero Delgado (Eds.), *Selección de lecturas de Metodología de la investigación Educativa* (pp. 32-45). Editorial Pueblo y Educación.

Cerezal Mezquita, J., & Fiallo Rodríguez, J. (2004). *Como investigar en Pedagogía*. Editorial Pueblo y Educación.

Chávez Zaldivar, N., & Huepp Ramos, F. L. (2014). *Fundamentos pedagógicos para la atención a escolares con necesidades educativas especiales.* Editorial Pueblo y Educación.

Chirino Ramos, M. V., Vázquez Conde, J. P., del Canto Colls, C., Escalona Serrano, E., & Suárez Méndez, C. (2013). *Sistematización teórica de los principales resultados aportados en la investigación educativa y su introducción atendiendo a las características de estos*. Editorial Pueblo y Educación.

Cobas Ochoa, C. L. (2010). *Temas logopédicos para los docentes*. Editorial Pueblo y Educación.

Cobas Ochoa, C. L., & Gárciga Domínguez, A. (2013). *El logopeda en la institución educativa*. Editorial Pueblo y Educación.

Cruz, R. (2018). Inclusión, Discapacidad y Profesores: Algunas reflexiones para repensar las prácticas (Político- Educativas). *Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva*, *12*(2). https://doi.org/ http://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782018000200041

de Armas Ramírez, N., & Valle Lima, A. (2011). *Resultados científicos en la investigación educativa*. Editorial Pueblo y Educación.

Duran Noya, T. (2009). *Programa de terapia ocupacional para desarrollar el autovalidismo en escolares con discapacidad físico motoras asociada a una parálisis cerebral.* [Tesis de Maestría, Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona"]. La Habana.

Fernández Pérez de Alejo, G. (2008a). Atención a los niños con necesidades educativas especiales en el área del lenguaje en Cuba. Pueblo y Educación.

Fernández Pérez de Alejo, G. (2008b). La Atención Logopédica en la Edad Infantil. Editorial Pueblo y Educación.

Fernández Pérez de Alejo, G., & Huepp Ramos, F. (2014). *Fundamentos neuropsicológicos del lenguaje*. Editorial Pueblo y Educación.

Fernández Pérez de Alejo, G., & Rodríguez Fleitas, X. (2012). *Logopedia Primera Parte*. Pueblo y Educaciòn.

Figueredo Escobar, E. (1982). *Psicología del Lenguaje*. Editorial Pueblo y Educación.

Figueredo Escobar, E., Nieves Rivero, M. L., Pérez González, S., & Borges Rodríguez, S. (1984). *Logopedia. Tomo I*. Editorial Pueblo y Educación.

Friedrich, W. (1988). *Métodos de la investigación social marxista leninista*. Editorial de Ciencias Sociales.

García Batista, G., Addine Fernández, F., Piñón González, J., & Rodríguez del Castillo, M. A. (2011). *Investigación interdisciplinaria en las ciencias pedagógicas*. Editorial Pueblo y Educación.

García de la Figal Costales, A. E. (2016). *Teoría y metodología de la investigación científica.* Editorial Universitaria Félix Varela.

Gómez Tolón, J. (1999). *Rehabilitación psicomotriz en la atención precoz del niño*. Mira Editores.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). *Metodología de la investigación.* McGRAW-HILL.

Jara Caballero, M. (2018). *Desarrollo psicomotor en la primera infancia* [Trabajo académico presentado para optar el Título Profesional de Segunda Especialidad de Educación Inicial, Universidad Nacional de Tumbes]. Trujillo – Perú.

Labarrere, G., & Valdivia, G. (1989). *Pedagogía*. Editorial Pueblo y Educación.

Liublinskaia, A. A. (1981). *Psicología Infantil*. Editorial de libros para la educación.

Lozano Sánchez, Z. B. (2020). *Problemas y trastornos del lenguaje en la niñez. Aportes a la educación y a la familia* (1 ed.). Fondo Editorial de la Universidad Privada Antenor Orrego.

Mancebo Calzado, M. S. (2010). *La formación de la disciplina como un valor social en el escolar primario desde la relación escuela-comunidad.* [Tesis presentada en opción al grado científico de doctor en ciencias pedagógicas. , UCP "Frank País García"]. Santiago de Cuba.

Mesa Leon, L. M., & Palacios Mazabel, N. (2013). *Acercamiento a las prácticas pedagógicas de los agentes educativos en la enseñanza de actividades de autocuidado en niños de párvulos.* Universidad del Valle]. Santiago de Cali.

Montiel Ramos, I. (2017). *estrategia didáctica para la profesionalización de los recursos tecnológicos en la formación inicial de maestros logopedas* [Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas., Universidad "Ignacio Agramonte Loynaz"]. Camagüey. https://docplayer.es/223449195-Universidad-de-camaguey-ignacio-agramonte-loynaz.html

Morales, M. E. (2004). *Enfoque práctico de la Logopedia.* Editorial Pueblo y Educación. .

Navarro Quintero, S. M. (2006). *Una concepción pedagógica para el proceso de tránsito a la educación media superior de los alumnos con limitaciones físico-motoras* [Tesis doctoral, Instituto Central del Ciencias Pedagógicas]. La Habana.

Nocedo de León, I., Catellanos Simons, B., García Batista, G., Addine Fernández, F., González Dosil, C., Gort Sánchez, M., Ruiz Aguilera, A., Minujín Zmud, A. F., & Valera Alfonso, O. (2001). *Metodología de la investigación educacional. Segunda Parte.* Pueblo y Educación.

Pérez Rodríguez, G., García Batista, G., Nocedo de León, I., & García Inza, M. L. (2009). *Metodología de la investigación educacional. Primera parte*. Editorial Pueblo y Educación.

Puentes. (2005). *Educación de los Alumnos con Limitaciones Físico Motoras.* Editorial Pueblo y Educación.

San Pedro Virués, J. M. (2008). Estimulación física y terapéutica en los trastornos ortopédicos de cadera en Parálisis Cerebral Infantil *EFDeportes.com*, *Año 13*(126).

Sánchez Valdés, X. (2017). *La superación de los maestros ambulantes sobre el desarrollo de la psicomotricidad de los alumnos con limitaciones físico–motoras por parálisis cerebral* [Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, Universidad de Pinar del Río"Hermanos Saíz Montes de Oca"]. Pinar del Río. https://docplayer.es/205934855-Republica-de-cuba-universidad-de-pinar-del-rio-hermanos-saiz-montes-de-oca-titulo-la-superacion-de-los-maestros-ambulantes-sobre-el.html

Sierra Salcedo, R. A., & Caballero Delgado, E. (2009). *Selección de lecturas de metodología de la investigación educativa*. Editorial Pueblo y Educación.

Valle Lima, A. (2007). *Meta modelos de la investigación pedagógica.* . ICCP

Valle Lima, A. (2010). *Algunos resultados científicos pedagógicos Vías para su obtención*. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.

Anexo 1

Guía de entrevista a rehabilitadores acerca del conocimiento que poseen sobre la disartria y las actividades que realizan para favorecer la labor compensatoria de esta patología en escolares con discapacidad físico motoras durante los turnos de Terapia Ocupacional.

Preguntas:

1-¿Conoce usted que es la Disartria, cuáles son sus Características y clasificaciones?

2-¿Conoce cuáles son las repercusiones que puede tener este trastorno en el desarrollo de la vida social de un escolar con discapacidad físico motora?

3-¿Conoce cuáles de los escolares que atiende poseen este trastorno?

4-Que actividades realiza usted desde su clase para favorecer el desarrollo del lenguaje de sus escolares?

5-¿Considera usted importante el tratamiento a la disartria desde los turnos de Terapia Ocupacional?

Anexo 2

Guía de Observación

- Acciones y actividades que realizan los rehabilitadores, para el desarrollo de la expresividad verbal en escolares con disartria durante los turnos de Terapia Ocupacional
- Conocimiento de los escolares con trastornos del lenguaje
- Cumplimiento de las orientaciones logopédicas por los rehabilitadores durante los turnos de Terapia Ocupacional
- Integración de la atención del lenguaje a la rehabilitación física de los escolares con discapacidad físico motora

Anexo 3

Entrevista a maestros para evaluar la efectividad de la metodología propuesta

Preguntas:

1) ¿Considera usted que la estrategia propuesta le ha permitido la preparación para la atención correctiva a los escolares con discapacidad físico motoras que presentan Disartria?
2) ¿Exprese su opinión acerca de los resultados obtenidos en los escolares con discapacidad físico motoras que presentan Disartria mediante la aplicación de la estrategia a partir de su implementación en los talleres de terapia ocupacional?
3) ¿Explique cómo llevo a cabo la aplicación de la estrategia en los talleres de Terapia Ocupacional?
4) ¿Qué recomendaciones realizarías para valorar la efectividad de la aplicación de la propuesta?

Anexo 4

Encuesta a especialistas para evaluar la efectividad de la propuesta

1) Exponga su criterio acerca de la estructura de la estrategia didáctica para la atención correctiva de la disartria a partir de su implementación en los talleres de terapia ocupacional.

2) Exponga su criterio acerca de la importancia de la estrategia didáctica propuesta para la adecuada atención diferenciada de los escolares con discapacidad físico motoras que presentan dificultades en el lenguaje.

3) Valore la estrategia como guía para evaluar el desarrollo de la del lenguaje y la expresión oral en escolares con discapacidad físico motoras

4) Ofrezca las recomendaciones que permita enriquecer la estrategia.